G7 — Bouffées vasomotrices (flush) · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v1

LOT_007 audité · Phase A + Phase B (DX.1–12) · 98 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 58 EX · 24 AP · 16 SPE

🧭 Carte mentale G7 · 60 secondes avant de répondre

EX **Examen** — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP **Approfondissement** — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité **Spécialiste** — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant un flush

1. **Drapeau rouge ?** Hypotension, œdème de la langue ou de la gorge ; hypertension sévère paroxystique avec céphalées ; diarrhée avec sifflements ; souffle droit ; fièvre avec frissons ou confusion ; tachycardie majeure fébrile ; masse cervicale dure avec diarrhée.
2. **Sec ou humide ?** Humide (sueurs) : ménopause, catécholamines, fièvre, thyrotoxicose ; sec : carcinoïde, mastocytose, médicaments.
3. **Quel déclencheur, quel terrain ?** Alcool (minutes), médicament récent, chaleur et épices, peur ; âge, cycle, dernières règles ; goitre, nodule, antécédent familial de tumeur endocrine.

🌡️ Causes courantes

- Femme > 45 ans, bouffées humides, TSH normale → clinique, pas de FSH (DX.1)
- Rougeur centrofaciale persistante, sans comédons → rosacée (DX.2)
- Peur, examen et TSH normaux → exclusion, TCC (DX.3)

💊 Réactionnel

- Minutes après l'alcool, Asie de l'Est → ALDH2 ; abstinence (DX.5)
- Amlodipine, niacine (PGD2), vancomycine ≤ 10 mg/min (DX.6)
- Persiste à l'arrêt → chercher DX.9–11

🧪 Examen qui tranche

- TSH puis fT4/T3 (DX.4)
- Métanéphrines plasmatiques libres (DX.10)
- 5-HIAA urinaire 24 h, sans banane ni noix (DX.9)
- Tryptase basale > 20 µg/L → moelle (DX.11)
- Calcitonine devant un nodule (DX.12)

🚩 Ordre d'exclusion

1. E1 Anaphylaxie (DX.8)
2. E2 Fièvre avec sepsis (DX.7)
3. E3 Phéochromocytome (DX.10)
4. E4 Thyrotoxicose décompensée (DX.4)
5. E5 Syndrome carcinoïde (DX.9)
6. E6 Mastocytose systémique (DX.11)
7. E7 Carcinome médullaire (DX.12)

Métanéphrines libres : sensibilité 99 %, spécificité 89 % ; 36 à 40 % des anaphylaxies ont une tryptase normale ; NT-proBNP < 260 pg/mL : VPN 97 % pour la cardiopathie carcinoïde.

① Raisonner · 30 Q · avant de nommer le diagnostic

Devant un flush : signes vitaux d'abord. Hypotension ou œdème laryngé → adrénaline i.m. ; hypertension paroxystique → alphabloquant avant bêtabloquant ; fièvre avec confusion → antibiotique en 1 h ; tachycardie fébrile → soins intensifs. Puis sec ou humide, déclencheur, médicaments.

Q1 **EX** **DX.8 · flush et hypotension** Prise en charge · urgences

Une femme de 34 ans est amenée 10 minutes après avoir mangé un plat contenant des noix de cajou. Elle a un flush du visage et du thorax, une urticaire généralisée et une gêne respiratoire. PA 78/45 mmHg, FC 128/min, SpO2 91 %.

Quelle est la première mesure la plus appropriée ?

A Clémastine i.v. puis réévaluation

B Prélever la tryptase avant tout traitement

C Adrénaline 0,3 mg i.m. à la cuisse

D Méthylprednisolone i.v. en bolus

E Salbutamol en aérosol seul

Q2 **EX** **DX.8 · position** Prise en charge · domicile

Un homme de 45 ans piqué par une guêpe il y a 5 minutes est pâle, couvert d'urticaire, et dit qu'il va s'évanouir. Il veut se lever pour aller aux toilettes. Il vient de recevoir 0,3 mg d'adrénaline i.m. de son autoinjecteur. Il respire sans difficulté.

Quelle consigne est la plus appropriée ?

- **A** Rester couché, jambes surélevées
- **B** Marcher pour activer la circulation
- **C** Position assise, jambes pendantes
- **D** Debout, appuyé contre un mur
- **E** Position ventrale pour libérer les voies aériennes

Q3 **EX** **DX.8 · surveillance** Prise en charge · urgences

Une femme de 28 ans a reçu de l'adrénaline i.m. pour une anaphylaxie alimentaire il y a 45 minutes. Elle va bien : PA 118/72 mmHg, plus d'urticaire, auscultation libre. Elle demande à rentrer chez elle.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Sortie immédiate avec antihistaminique
- **B** Sortie après une dose de corticoïde oral unique
- **C** Observation prolongée de plusieurs heures
- **D** Hospitalisation de 7 jours en médecine interne
- **E** Test cutané immédiat à l'allergène

Q4 **EX** **DX.10 vs DX.3 · crise paroxystique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 41 ans décrit depuis 4 mois des crises brutales de céphalées, palpitations et sueurs, avec pâleur puis rougeur, de 20 minutes. On l'a étiqueté anxieux. PA mesurée pendant une crise : 210/115 mmHg ; 132/84 mmHg entre les crises.

Quel examen est le plus approprié en premier ?

- **A** TDM des surrénales sans biologie
- **B** 5-HIAA urinaire des 24 heures
- **C** Tryptase sérique basale
- **D** Échelle d'anxiété et TCC d'emblée
- **E** Métanéphrines plasmatiques libres

Q5 **EX** **DX.10 · alpha avant bêta** Prise en charge · urgences

Une femme de 52 ans a des métanéphrines plasmatiques libres très élevées et une masse surrénalienne droite de 4 cm. Elle se présente pour palpitations : FC 124/min, PA 176/104 mmHg. L'interne propose du propranolol.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Propranolol seul pour ralentir le cœur
- **B** Alphabloquant d'abord, bêtabloquant ensuite
- **C** Glucagon pour soutenir le cœur
- **D** Surrénalectomie en urgence sans préparation
- **E** Diurétique de l'anse en bolus

Q6 **EX** **DX.10 · crise hypertensive** Prise en charge · urgences

Un homme de 48 ans avec phéochromocytome connu, non encore opéré, arrive en crise : PA 220/125 mmHg, céphalée intense, sueurs. ECG sans signe d'ischémie, glycémie 6,1 mmol/L.

Quel traitement immédiat est le plus approprié ?

- **A** Urapidil i.v. 10 à 50 mg, patient couché
- **B** Métoprolol i.v. en bolus
- **C** Nifédipine sublinguale et sortie
- **D** Glucagon 1 mg i.m.
- **E** Observation sans traitement pendant 2 heures

Q7 **EX** **DX.7 · flush fébrile grave** Prise en charge · urgences

Une femme de 74 ans est amenée pour flush, frissons et confusion depuis ce matin. T 39,4 °C, FR 26/min, PA 92/55 mmHg. Elle a des brûlures mictionnelles depuis 3 jours.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Paracétamol et contrôle de la température à 2 h
- **B** 5-HIAA urinaire pour flush avec frissons
- **C** Uroculture puis attente du résultat
- **D** Hémocultures et antibiotique dans l'heure
- **E** Adrénaline i.m. pour hypotension avec flush

Q8 **EX** **DX.7 · hyperthermie** Prise en charge · urgences

Un homme de 30 ans sous neuroleptique est amené par une chaude journée d'été : il est rouge, confus, la peau sèche. T rectale 40,6 °C. Il a reçu 1 g de paracétamol il y a 1 heure, sans effet.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Deuxième dose de paracétamol 1 g
- **B** Refroidissement externe immédiat
- **C** Métamizole i.v.
- **D** Attendre le résultat des hémocultures
- **E** Ibuprofène 400 mg per os

Q9 **EX** **DX.4 · orage thyréotoxique** Prise en charge · urgences

Une femme de 38 ans avec maladie de Basedow, qui a arrêté son traitement, est amenée agitée et confuse. T 39,8 °C, FC 168/min irrégulière, flush et sueurs profuses. TSH effondrée.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Soins intensifs, thyréostatique et bêtabloquant
- **B** Iode radioactif en urgence
- **C** Paracétamol et retour à domicile
- **D** Scintigraphie thyroïdienne avant tout traitement
- **E** Thyroïdectomie totale dans l'heure

Q10 **EX** **DX.9 · flush sec et diarrhée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 63 ans consulte pour des flushs secs, brefs, du visage et du thorax, et une diarrhée aqueuse de 6 selles par jour depuis 2 mois. Il siffle parfois. Le foie est palpable, nodulaire.

Quel examen est le plus approprié pour confirmer le diagnostic ?

- **A** Métanéphrines plasmatiques libres
- **B** Chromogranine A sérique seule
- **C** 5-HIAA urinaire des 24 heures
- **D** Calcitonine sérique
- **E** FSH et estradiol

Q11 **EX** **DX.9 · bilan cardiaque** Prise en charge · policlinique

Un homme de 66 ans a un syndrome carcinoïde confirmé (5-HIAA 410 µmol/24 h) avec métastases hépatiques. Il n'a ni dyspnée ni œdème. L'auscultation est jugée normale.

Quel examen est le plus approprié ensuite ?

- **A** Aucun examen cardiaque si l'auscultation est normale
- **B** Coronarographie
- **C** Holter de 24 heures seul
- **D** NT-proBNP et échocardiographie
- **E** Épreuve d'effort

Q12 **EX** **DX.9 · avant anesthésie** Prise en charge · hôpital

Une femme de 58 ans avec syndrome carcinoïde et métastases hépatiques doit subir une cholécystectomie. L'anesthésiste vous demande la préparation.

Quelle préparation est la plus appropriée ?

- **A** Adrénaline en prophylaxie systématique à l'induction
- **B** Octréotide i.v. préparé, sans sympathomimétique
- **C** Alphabloquant 2 semaines avant
- **D** Aucune préparation particulière
- **E** Arrêt de l'analogue 1 semaine avant

Q13 **EX** **DX.12 · avant chirurgie** Prise en charge · hôpital

Un homme de 39 ans a un carcinome médullaire de la thyroïde confirmé par cytologie (calcitonine 820 ng/L). Le chirurgien planifie la thyroïdectomie.

Quel examen faut-il obtenir avant l'opération ?

- **A** Métanéphrines plasmatiques libres
- **B** Scintigraphie à l'iode 131
- **C** 5-HIAA urinaire des 24 heures, sans banane
- **D** Tryptase sérique basale
- **E** FSH et LH

Q14 **EX** **DX.12 · nodule avec diarrhée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 47 ans consulte pour une diarrhée chronique et des flushs. Vous palpez un nodule thyroïdien dur de 2 cm avec une adénopathie cervicale. Sa mère a été opérée d'un « cancer de la thyroïde ».

Quel dosage est le plus approprié ?

- **A** Thyroglobuline sérique
- **B** 5-HIAA urinaire des 24 heures
- **C** Anticorps anti-TPO
- **D** Tryptase sérique basale
- **E** Calcitonine sérique

Q15 **EX** **DX.11 · anaphylaxie au venin** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 52 ans a fait deux chocs anaphylactiques après des piqûres de guêpe, sans urticaire. Il n'a aucune lésion cutanée. La tryptase prélevée 2 semaines après le dernier épisode est à 24 µg/L.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Rassurer : tryptase élevée par la crise
- **B** Antihistaminique seul au long cours
- **C** Biopsie de moelle osseuse
- **D** Échographie thyroïdienne
- **E** 5-HIAA urinaire des 24 heures

Q16 **EX** **DX.11 · trousse d'urgence** Prise en charge · cabinet

Une femme de 44 ans a une mastocytose systémique indolente confirmée. Elle a des flushs et du prurit, contrôlés par la cétirizine. Elle n'a jamais fait d'anaphylaxie.

Quel élément est le plus important à prescrire en plus ?

- **A** Avapritinib 200 mg par jour
- **B** Corticoïde oral au long cours
- **C** Doublement de la dose sans autre mesure
- **D** Deux autoinjecteurs d'adrénaline
- **E** Aucun traitement supplémentaire

Q17 **EX** **DX.1 vs DX.4 · TSH d'abord** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 49 ans consulte pour des bouffées de chaleur avec sueurs depuis 3 mois. Ses cycles sont irréguliers. Elle a perdu 4 kg, a des palpitations et un tremblement fin. T 37,1 °C.

Quel examen est le plus approprié en premier ?

- **A** FSH sérique
- **B** TSH
- **C** Estradiol sérique
- **D** Métanéphrines plasmatiques libres
- **E** Échographie pelvienne

Q18 **EX** **DX.1 · forme modérée** Prise en charge · cabinet

Une femme de 52 ans, aménorrhée depuis 14 mois, a 8 bouffées de chaleur par jour qui perturbent son sommeil. Elle a un utérus. Pas d'antécédent de cancer du sein ni de thrombose. TSH normale.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Estradiol transdermique plus progestatif
- **B** Estradiol transdermique seul
- **C** Clonidine orale en première ligne, au long cours
- **D** Gabapentine en première ligne
- **E** Phyto-œstrogènes de soja

Q19 **EX** **DX.1 · début précoce** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 32 ans consulte pour des bouffées de chaleur et une aménorrhée de 5 mois. Test de grossesse négatif. TSH normale.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** THM sans bilan, comme une ménopause
- **B** Fézolinétant 45 mg par jour
- **C** Rassurer et revoir dans 1 an
- **D** Métanéphrines plasmatiques libres
- **E** FSH et estradiol

Q20 **EX** **DX.3 · douleur thoracique** Prise en charge · urgences

Une femme de 46 ans, connue pour un trouble panique, consulte pour une crise avec rougeur, sueurs, palpitations et douleur thoracique oppressive depuis 30 minutes. PA 148/90 mmHg, FC 104/min.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** ECG et troponine
- **B** Lorazépam et retour à domicile
- **C** Exercice de respiration lente seul
- **D** Augmenter l'escitalopram
- **E** Rendez-vous de psychothérapie

Q21 **EX** **DX.6 · red man** Prise en charge · hôpital

Un homme de 58 ans reçoit sa première dose de vancomycine 1 g i.v. en 15 minutes. Il présente une rougeur du visage et du torse avec prurit. PA 126/78 mmHg, pas de stridor, pas d'urticaire, auscultation libre.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Adrénaline 0,3 mg i.m.
- **B** Contre-indication définitive à la vancomycine
- **C** Poursuivre au même débit
- **D** Arrêter, puis reprendre à ≤ 10 mg/min
- **E** Remplacer par un dérivé nitré

Q22 **EX** **DX.6 · nitré et PDE5** Prise en charge · urgences

Un homme de 64 ans angineux prend de la nitroglycérine sublinguale pour une douleur thoracique. Il a pris du sildénafil 4 heures plus tôt. Il est rouge, vertigineux. PA 72/40 mmHg.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Nouvelle dose de nitroglycérine
- **B** Allonger, remplir, surveiller monitoré
- **C** Adrénaline i.m. pour flush avec hypotension
- **D** Retour à domicile après 30 minutes de repos
- **E** Propranolol i.v.

Q23 **EX** **DX.5 vs DX.8 · alcool et stridor** Prise en charge · urgences

Un homme de 35 ans développe, 20 minutes après deux verres de vin au restaurant, un flush, une urticaire, un stridor et une PA à 84/50 mmHg.

Quel est le premier geste le plus approprié ?

- **A** Disulfirame pour bloquer l'acétaldéhyde
- **B** Adrénaline i.m.
- **C** Rassurer : flush alcoolique bénin
- **D** Antihistaminique oral et observation
- **E** Test génétique ALDH2

Q24 **EX** **DX.4 · agranulocytose** Prise en charge · cabinet

Une femme de 36 ans prend du carbimazole 30 mg par jour depuis 5 semaines pour une maladie de Basedow. Elle appelle pour une fièvre à 39 °C et une angine.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Arrêter et faire une formule sanguine
- **B** Amoxicilline et poursuite du carbimazole
- **C** Augmenter le carbimazole
- **D** Paracétamol et contrôle dans 1 semaine
- **E** Passer à l'iode radioactif dans la semaine

Q25 **EX** **DX.2 · œil douloureux** Prise en charge · cabinet

Un homme de 55 ans suivi pour une rosacée consulte pour un œil droit rouge et douloureux, avec photophobie et baisse de vision depuis la veille.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Larmes artificielles et contrôle dans 1 mois
- **B** Brimonidine gel autour de l'œil
- **C** Collyre corticoïde sans examen
- **D** Avis ophtalmologique urgent
- **E** Ivermectine crème sur les paupières

Q26 **SPE · Anesthésiologie** **DX.10 · crise peropératoire** Prise en charge · hôpital

Pendant une surrénalectomie laparoscopique pour phéochromocytome, préparée par alpha-blocage, la PA monte à 230/120 mmHg lors de la manipulation de la tumeur.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Propranolol i.v. en premier
- **B** Nitroprussiate i.v. à 0,2 µg/kg/min
- **C** Glucagon i.v.
- **D** Noradrénaline en perfusion
- **E** Arrêt définitif de l'intervention chirurgicale

Q27 **SPE · Anesthésiologie** **DX.9 · hypotension au bloc** Prise en charge · hôpital

Pendant une résection de métastases hépatiques chez un patient carcinoïde, un flush brutal apparaît avec PA 70/40 mmHg et bronchospasme, malgré le remplissage et l'octréotide i.v.

Quel vasopresseur est le plus approprié ?

- **A** Adrénaline en bolus répétés
- **B** Éphédrine i.v. en bolus
- **C** Phényléphrine ou vasopressine
- **D** Dobutamine en perfusion continue
- **E** Isoprénaline

Q28 **SPE · Endocrinologie** **DX.12 · hypocalcémie postopératoire** Prise en charge · hôpital

Le lendemain d'une thyroïdectomie totale avec curage central pour carcinome médullaire, une femme de 50 ans a des paresthésies péribuccales et des crampes. Signe de Chvostek positif.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Lévothyroxine à dose suppressive
- **B** Calcium i.v. lent sous scope
- **C** Calcitriol seul et contrôle dans 1 mois
- **D** Furosémide i.v.
- **E** Reprise chirurgicale immédiate

Q29 **AP** **DX.7 · fièvre inexpliquée** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 55 ans, immunocompétent, a une fièvre à 38,6 °C mesurée à plusieurs reprises depuis 5 semaines, avec bouffées de chaleur nocturnes. Le bilan minimal standard (examen, formule, CRP, hémocultures, urines, radiographie du thorax) n'a rien trouvé.

Quel examen est le plus approprié ensuite ?

- **A** Antibiotique d'épreuve
- **B** Corticoïde d'épreuve
- **C** FSH et estradiol
- **D** PET-TDM
- **E** Répéter le même bilan dans 6 mois

Q30 **SPE · Médecine intensive** **DX.8 · choc réfractaire** Prise en charge · urgences

Une femme de 60 ans en anaphylaxie a reçu deux doses d'adrénaline i.m., de l'oxygène et 2 L de cristalloïde. PA 70/40 mmHg persistante.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Troisième dose d'antihistaminique H1 par voie i.v.
- **B** Corticoïde i.v. seul
- **C** Adrénaline i.v. titrée en soins monitorés
- **D** Attendre la tryptase
- **E** Retour à la position assise

② Discriminer · 50 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 12 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

Q31 **EX** **DX.1 · diagnostic clinique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 51 ans a depuis 6 mois des accès de chaleur du visage et du thorax suivis de sueurs, de 2 à 3 minutes, et des sueurs nocturnes. Cycles irréguliers. Examen normal, T 36,8 °C. TSH normale.

Quelle est la conduite diagnostique la plus appropriée ?

- **A** FSH sérique pour confirmer le diagnostic
- **B** Estradiol et LH sériques
- **C** 5-HIAA urinaire des 24 heures
- **D** Tryptase sérique basale
- **E** Diagnostic clinique, sans dosage

Q32 **EX** **DX.1 · voie non hormonale** Prise en charge · cabinet

Une femme de 56 ans, traitée il y a 3 ans pour un cancer du sein, a des bouffées sévères. Bilan hépatique normal, DFGe 82 mL/min/1,73 m². Elle ne prend aucun médicament.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Estradiol transdermique
- **B** Fézolinétant 45 mg par jour
- **C** Tibolone 2,5 mg par jour
- **D** Estradiol plus dydrogestérone
- **E** Clonidine en première ligne

Q33 **EX** **DX.1 · surveillance VEOZA** Prise en charge · cabinet

Une femme de 54 ans va débuter le fézolinétant pour des bouffées modérées. Elle demande quel suivi est nécessaire.

Quel suivi est le plus approprié ?

- **A** ECG avant le début, puis à 1 mois
- **B** Bilan hépatique avant, puis mensuel
- **C** FSH tous les 3 mois
- **D** Formule sanguine hebdomadaire 6 semaines
- **E** Mammographie mensuelle

Q34 **EX** **DX.2 vs DX.1 · rougeur persistante** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 48 ans consulte pour des rougeurs du visage déclenchées par la chaleur, l'alcool et les épices. Entre les épisodes persistent un érythème centrofacial, des télangiectasies et quelques papulopustules, sans comédons. Cycles réguliers.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Bouffées de la ménopause
- **B** Acné vulgaire
- **C** Mastocytose systémique
- **D** Rosacée
- **E** Syndrome carcinoïde

Q35 **EX** **DX.2 · papulopustules** Prise en charge · cabinet

Un homme de 52 ans a une rosacée avec de nombreuses papulopustules des joues et du menton (IGA 3). Pas d'atteinte oculaire.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Ivermectine crème 1 g par jour
- **B** Brimonidine gel seul
- **C** Dermocorticoïde puissant
- **D** Isotrétinoïne orale
- **E** Acide azélaïque, indication AIPS rosacée

Q36 **EX** **DX.2 · érythème** Prise en charge · cabinet

Une femme de 46 ans a une rosacée érythémateuse sans papules. Elle souhaite atténuer la rougeur avant des réunions.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Ivermectine crème
- **B** Dermocorticoïde de classe III
- **C** Propranolol 40 mg
- **D** Brimonidine gel une fois par jour
- **E** Doxycycline 200 mg par jour pendant 3 mois

Q37 **EX** **DX.3 · diagnostic d'exclusion** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un étudiant de 23 ans rougit et transpire dès qu'il doit parler en public, depuis plusieurs années. Il évite les présentations. Examen normal, PA 122/76 mmHg, TSH normale.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Phéochromocytome
- **B** Hyperthyroïdie
- **C** Flush émotionnel
- **D** Syndrome carcinoïde
- **E** Rosacée

Q38 **EX** **DX.3 · traitement de fond** Prise en charge · cabinet

Une femme de 31 ans a un trouble anxieux généralisé avec épisodes de rougeur et sueurs. Bilan somatique et TSH normaux. Elle souhaite un traitement durable.

Quel traitement de fond est le plus approprié en première intention ?

- **A** Psychothérapie cognitivo-comportementale
- **B** Lorazépam 1 mg trois fois par jour au long cours
- **C** Propranolol au long cours seul
- **D** Fézolinétant
- **E** Brimonidine gel

Q39 **EX** **DX.3 vs DX.4 · anxieux avec TSH basse** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 29 ans se dit anxieuse depuis 2 mois : flushs, palpitations, insomnie, perte de 3 kg. FC 112/min. TSH < 0,01 mUI/L, fT4 élevée.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Trouble anxieux généralisé
- **B** Trouble panique
- **C** Bouffées de la ménopause
- **D** Flush médicamenteux
- **E** Hyperthyroïdie

Q40 **EX** **DX.4 · diagnostic biologique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 44 ans a une thermophobie, des sueurs, des flushs humides et un tremblement fin. FC 108/min. TSH 0,02 mUI/L.

Quel examen est le plus approprié pour confirmer l'hyperthyroïdie franche ?

- **A** Scintigraphie en premier
- **B** Anticorps anti-TPO
- **C** Calcitonine sérique
- **D** fT4 et T3
- **E** Répéter la TSH dans 6 mois

Q41 **EX** **DX.4 · grossesse** Prise en charge · hôpital

Une femme de 30 ans enceinte de 8 semaines a une maladie de Basedow active : TSH supprimée, fT4 élevée, TSH-R-Ab positifs.

Quel thyréostatique est le plus approprié ?

- **A** Carbimazole
- **B** Iode radioactif
- **C** Propranolol seul au long cours
- **D** Lévothyroxine
- **E** Propylthiouracile

Q42 **EX** **DX.4 · TSH normale** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 50 ans a des bouffées humides et des palpitations. TSH 1,8 mUI/L. PA 124/78 mmHg, sans crise hypertensive. Aménorrhée depuis 8 mois.

Quelle conclusion est la plus appropriée concernant la thyroïde ?

- **A** Doser fT3 pour exclure une T3-toxicose
- **B** Hyperthyroïdie exclue
- **C** Scintigraphie thyroïdienne
- **D** Thyréostatique d'épreuve
- **E** Anticorps anti-récepteur de la TSH

Q43 **EX** **DX.5 · déficit en ALDH2** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 26 ans d'origine japonaise rougit intensément 5 à 10 minutes après chaque verre d'alcool, quelle que soit la boisson. Il n'a jamais de flush sans alcool. Il ne prend aucun médicament.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Syndrome carcinoïde
- **B** Déficit en ALDH2
- **C** Mastocytose systémique
- **D** Rosacée
- **E** Phéochromocytome

Q44 **EX** **DX.5 · métronidazole** Prise en charge · cabinet

Une femme de 38 ans débute du métronidazole pour une vaginite à Gardnerella. Elle demande si elle peut boire du vin au mariage de sa sœur dans 3 jours.

Quel conseil est le plus approprié ?

- **A** Alcool permis en petite quantité
- **B** Alcool permis après la première dose
- **C** Aucun alcool pendant et le jour suivant
- **D** Arrêter le métronidazole le jour du mariage
- **E** Prendre un antihistaminique avant de boire

Q45 **EX** **DX.5 · sous disulfirame** Prise en charge · cabinet

Un homme de 49 ans a arrêté le disulfirame il y a 10 jours. Il demande s'il peut boire une bière.

Quel conseil est le plus approprié ?

- **A** Réaction possible jusqu'à 3 semaines
- **B** Aucun risque après 48 heures
- **C** Aucun risque après 7 jours
- **D** Risque seulement avec les alcools forts
- **E** Risque seulement s'il reprend le disulfirame

Q46 **EX** **DX.6 · inhibiteur calcique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 61 ans hypertendue a débuté l'amlodipine 5 mg il y a 10 jours. Elle a depuis des rougeurs du visage, bien tolérées. PA 136/82 mmHg. Examen normal.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Bouffées de la ménopause
- **B** Flush médicamenteux
- **C** Phéochromocytome
- **D** Rosacée
- **E** Anaphylaxie

Q47 **EX** **DX.6 · persistance** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 57 ans a arrêté la niacine il y a 4 semaines, mais ses flushs secs persistent et s'accompagnent de selles liquides.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** 5-HIAA urinaire des 24 heures
- **B** Rassurer : effet résiduel de la niacine
- **C** Reprendre la niacine avec aspirine
- **D** Aucun examen, contrôle dans 1 an
- **E** FSH sérique

Q48 **EX** **DX.7 · seuil de fièvre** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 47 ans dit avoir « de la fièvre » avec ses bouffées de chaleur. Elle se sent chaude, sans frissons. T tympanique 37,2 °C au cabinet.

Quel élément est le plus approprié pour affirmer une fièvre ?

- **A** Sensation de chaleur rapportée
- **B** Rougeur du visage
- **C** Température centrale mesurée ≥ 38,0 °C
- **D** Sueurs nocturnes
- **E** Mesure axillaire isolée à 37,9 °C, au domicile

Q49 **EX** **DX.7 · dose de paracétamol** Prise en charge · cabinet

Un homme de 70 kg a une grippe avec fièvre à 38,9 °C et frissons. Fonction rénale et hépatique normales.

Quelle posologie de paracétamol est la plus appropriée ?

- **A** 2 g toutes les 6 h
- **B** 1 g toutes les 6 h, max 4 g/j
- **C** 1 g toutes les 2 h
- **D** 500 mg une fois par jour
- **E** 1 g toutes les 4 h, max 6 g/j

Q50 **EX** **DX.8 · hypotension sans peau** Évaluation / diagnostic · domicile

Une femme de 57 ans, connue pour une allergie au venin de guêpe, est piquée au jardin. Quelques minutes plus tard, elle est vertigineuse, PA 76/44 mmHg. Aucune urticaire, aucun prurit.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Malaise vagal simple
- **B** Urticaire aiguë
- **C** Flush émotionnel
- **D** Anaphylaxie
- **E** Réaction locale étendue

Q51 **EX** **DX.8 · urticaire chronique** Prise en charge · cabinet

Une femme de 35 ans a des papules urticariennes prurigineuses fugaces presque chaque jour depuis 3 mois, sans angio-œdème ni déclencheur physique. Hémogramme et CRP normaux.

Quel traitement est le plus approprié en première ligne ?

- **A** Antihistaminique H1 de 2e génération
- **B** Corticoïde oral au long cours, à dose dégressive
- **C** Omalizumab d'emblée
- **D** Antihistaminique à la demande
- **E** Adrénaline autoinjectable seule

Q52 **EX** **DX.9 vs DX.1 · sec ou humide** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 53 ans décrit des flushs brefs du visage et du thorax, sans aucune sueur, avec des selles liquides 5 fois par jour et un sifflement à l'effort. Ménopausée depuis 2 ans.

Quel diagnostic faut-il évoquer en premier ?

- **A** Bouffées de la ménopause
- **B** Flush émotionnel
- **C** Syndrome carcinoïde
- **D** Rosacée
- **E** Flush lié à l'alcool

Q53 **EX** **DX.9 · première ligne** Prise en charge · policlinique

Un homme de 61 ans a un syndrome carcinoïde (TNE iléale G1, métastases hépatiques, récepteurs de la somatostatine positifs). Flushs et diarrhée quotidiens.

Quel traitement est le plus approprié en première ligne ?

- **A** Évérolimus
- **B** Lutécium-177 d'emblée
- **C** Analogue de la somatostatine
- **D** Télotristat seul
- **E** Lopéramide seul, à dose maximale quotidienne

Q54 **EX** **DX.10 · biologie avant imagerie** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un scanner fait pour des douleurs lombaires découvre une masse surrénalienne gauche de 3 cm chez un homme de 58 ans hypertendu. Le radiologue propose une biopsie.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Biopsie scanoguidée
- **B** Surrénalectomie sans bilan
- **C** Scintigraphie MIBG d'emblée
- **D** Métanéphrines avant tout geste
- **E** Surveillance par scanner à 1 an

Q55 **EX** **DX.10 · glucagon** Prise en charge · urgences

Un homme diabétique insulinotraité de 56 ans, avec phéochromocytome suspecté, est trouvé hypoglycémique (2,4 mmol/L), conscient, avec une voie veineuse.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Glucagon 1 mg i.m.
- **B** Adrénaline s.c.
- **C** Attendre la glycémie de contrôle
- **D** Octréotide s.c.
- **E** Glucose i.v.

Q56 **EX** **DX.11 vs DX.8 · signe de Darier** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 39 ans a des flushs, du prurit et des macules brunâtres du tronc. Le frottement doux d'une macule fait apparaître une papule urticarienne en quelques minutes.

Quel diagnostic ce signe évoque-t-il le plus ?

- **A** Urticaire chronique inductible
- **B** Rosacée
- **C** Mastocytose
- **D** Syndrome carcinoïde
- **E** Flush médicamenteux

Q57 **EX** **DX.11 · tryptase** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 47 ans a des flushs secs récurrents et une hépatosplénomégalie. Tryptase basale hors crise : 38 µg/L.

Quel examen est le plus approprié ensuite ?

- **A** Métanéphrines plasmatiques libres
- **B** Biopsie de moelle osseuse
- **C** Calcitonine sérique
- **D** Répéter la tryptase dans 2 ans
- **E** Test cutané aux pneumallergènes

Q58 **EX** **DX.12 · RET** Prise en charge · policlinique

Un homme de 42 ans a un carcinome médullaire de la thyroïde opéré. Il a deux enfants de 8 et 12 ans.

Quelle mesure est la plus appropriée ?

- **A** Test génétique seulement si antécédent familial
- **B** Calcitonine annuelle des enfants sans génétique
- **C** Thyroïdectomie prophylactique sans test
- **D** Aucune mesure familiale
- **E** Test RET du patient puis des apparentés

Q59 **EX** **DX.12 · traitement curatif** Prise en charge · hôpital

Une femme de 45 ans a un carcinome médullaire de 1,8 cm avec adénopathie centrale, métanéphrines normales.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Iode radioactif après lobectomie
- **B** Lobectomie seule
- **C** Sélpercatinib en première ligne
- **D** Surveillance semestrielle de la calcitonine et de l'ACE
- **E** Thyroïdectomie totale avec curage central

Q60 **AP** **DX.1 · mécanisme KNDy** Mécanismes · cabinet

Une femme de 53 ans sous fézolinétant pour des bouffées sévères demande comment agit ce médicament non hormonal.

Quel mécanisme explique le mieux son effet ?

- **A** Agonisme des récepteurs aux œstrogènes
- **B** Inhibition de la recapture de la sérotonine
- **C** Agonisme alpha-2 central
- **D** Blocage du récepteur NK3 hypothalamique
- **E** Inhibition de la COX

Q61 **AP** **DX.1 · CYP1A2** Prise en charge · cabinet

Une femme de 55 ans souhaite le fézolinétant pour des bouffées modérées. Elle prend de la fluvoxamine pour un trouble obsessionnel. Bilan hépatique et DFGe normaux.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Fézolinétant 45 mg, dose habituelle
- **B** Fézolinétant 90 mg par jour
- **C** Fézolinétant un jour sur deux
- **D** Fézolinétant après dosage de la FSH
- **E** Ne pas prescrire le fézolinétant

Q62 **AP** **DX.2 · dermocorticoïde** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 40 ans applique depuis 4 mois un dermocorticoïde puissant sur une rougeur du visage. La rougeur s'aggrave, avec papules et télangiectasies.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Sevrage progressif du dermocorticoïde
- **B** Augmenter la puissance du dermocorticoïde
- **C** Arrêt brutal et isotrétinoïne
- **D** Ajouter la brimonidine et poursuivre
- **E** Biopsie cutanée immédiate

Q63 **AP** **DX.3 · propranolol et asthme** Prise en charge · cabinet

Un homme de 34 ans asthmatique demande du propranolol pour son trac avec rougeur et tachycardie avant ses concerts.

Quelle réponse est la plus appropriée ?

- **A** Propranolol 40 mg avant chaque concert
- **B** Propranolol contre-indiqué : asthme
- **C** Propranolol avec salbutamol en prévention
- **D** Propranolol à demi-dose
- **E** Propranolol en patch

Q64 **AP** **DX.4 · TSH-R-Ab** Évaluation / diagnostic · policlinique

Une femme de 33 ans a une TSH supprimée et une fT4 élevée. Elle a une exophtalmie et un goitre diffus.

Quel examen confirme le plus directement la cause ?

- **A** Anticorps anti-récepteur de la TSH
- **B** Calcitonine sérique
- **C** Thyroglobuline
- **D** Cytoponction échoguidée du goitre diffus
- **E** TDM cervicale injectée

Q65 **AP** **DX.4 · propranolol masque** Mécanismes · cabinet

Un homme de 40 ans en thyrotoxicose reçoit du propranolol. Ses palpitations et son tremblement disparaissent ; il veut arrêter le reste du bilan.

Quelle explication est la plus appropriée ?

- **A** Le propranolol normalise la fT4
- **B** Le propranolol guérit la maladie de Basedow
- **C** Le propranolol remplace le thyréostatique à long terme
- **D** Le propranolol bloque les TSH-R-Ab
- **E** Le propranolol soulage sans traiter la cause

Q66 **AP** **DX.5 · acétaldéhyde** Mécanismes · cabinet

Un étudiant de 22 ans demande pourquoi il devient rouge après un seul verre de bière alors que ses amis non.

Quel mécanisme explique le mieux ce flush ?

- **A** Libération de sérotonine tumorale
- **B** Dégranulation mastocytaire clonale
- **C** Accumulation d'acétaldéhyde vasodilatateur
- **D** Excès de catécholamines
- **E** Libération de prostaglandine D2 par la niacine

Q67 **AP** **DX.5 · risque œsophagien** Prise en charge · cabinet

Un homme de 30 ans d'origine coréenne, avec déficit en ALDH2 probable, boit 3 bières par soir « pour s'habituer » au flush.

Quel conseil est le plus approprié ?

- **A** Continuer pour induire une tolérance
- **B** Abstinence : risque de cancer de l'œsophage
- **C** Antihistaminique H1 pris une heure avant de boire
- **D** Disulfirame pour réduire le flush
- **E** Aucune mesure : flush bénin

Q68 **AP** **DX.6 · niacine et PGD2** Mécanismes · cabinet

Un homme de 59 ans qui prend de la niacine pour une dyslipidémie a un flush 30 minutes après chaque dose.

Quel mécanisme explique le mieux ce flush ?

- **A** Accumulation d'acétaldéhyde
- **B** Libération d'histamine dépendante du débit
- **C** PGD2 sur le récepteur DP1 cutané
- **D** Blocage des canaux calciques
- **E** Sérotonine d'origine tumorale

Q69 **AP** **DX.6 · red man non allergique** Mécanismes · hôpital

Une infirmière demande si un patient ayant eu un « red man » sous vancomycine doit être étiqueté allergique.

Quelle réponse est la plus appropriée ?

- **A** Oui : allergie IgE vraie
- **B** Oui : contre-indication définitive
- **C** Non : histamine liée au débit
- **D** Non : réaction à l'excipient
- **E** Oui : désensibilisation obligatoire

Q70 **AP** **DX.8 · tryptase normale** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 41 ans a eu une urticaire généralisée avec bronchospasme et hypotension après une crevette, corrigés par l'adrénaline. La tryptase prélevée à 1 heure est à 9 µg/L.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Anaphylaxie exclue par la tryptase
- **B** Réaction vagale
- **C** Flush émotionnel
- **D** Asthme isolé
- **E** L'anaphylaxie reste le diagnostic

Q71 **AP** **DX.8 · angio-œdème sous IEC** Mécanismes · urgences

Un homme de 66 ans sous lisinopril a un gonflement de la lèvre et de la langue, sans urticaire ni prurit. Il respire bien, SpO2 97 %, PA 148/88 mmHg.

Quel mécanisme explique le mieux ce tableau ?

- **A** Histamine mastocytaire
- **B** Acétaldéhyde
- **C** Bradykinine
- **D** Sérotonine
- **E** Catécholamines

Q72 **AP** **DX.9 · métastases hépatiques** Mécanismes · policlinique

Un étudiant demande pourquoi une tumeur neuroendocrine de l'iléon sans métastase ne donne habituellement pas de flush.

Quel mécanisme explique le mieux cette observation ?

- **A** La tumeur iléale ne sécrète pas de sérotonine
- **B** Le rein élimine toute la sérotonine
- **C** Les plaquettes détruisent la sérotonine
- **D** Le poumon capte toute la bradykinine
- **E** Le foie inactive les médiateurs portaux

Q73 **AP** **DX.9 · chromogranine A** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 64 ans a une TNE pancréatique non fonctionnelle. Sa chromogranine A est élevée. Il n'a ni flush ni diarrhée.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Syndrome carcinoïde confirmé
- **B** Phéochromocytome associé
- **C** Mastocytose associée
- **D** Pas de syndrome carcinoïde
- **E** Carcinome médullaire associé

Q74 **AP** **DX.10 · faux positif** Évaluation / diagnostic · policlinique

Un homme de 50 ans a des métanéphrines plasmatiques libres légèrement au-dessus de la norme, prélevées assis, après un café, sans crise ni hypertension.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** TDM des surrénales avec injection d'emblée
- **B** Alpha-blocage et chirurgie
- **C** Scintigraphie à la MIBG
- **D** Conclure au phéochromocytome
- **E** Refaire le dosage, couché 30 min, à jeun

Q75 **AP** **DX.10 · régime salé** Mécanismes · hôpital

Une femme de 45 ans est préparée à une surrénalectomie pour phéochromocytome. On lui prescrit un alphabloquant et un régime riche en sodium.

Quel est le but principal du régime salé ?

- **A** Prévenir l'hypokaliémie liée à l'alpha-blocage
- **B** Réduire la sécrétion tumorale
- **C** Prévenir l'hypoglycémie
- **D** Prévenir l'hypotension postopératoire
- **E** Améliorer la cicatrisation

Q76 **AP** **DX.11 · critères OMS** Évaluation / diagnostic · hôpital

La biopsie de moelle d'un homme de 50 ans montre des agrégats multifocaux denses de plus de 15 mastocytes. La mutation KIT D816V est présente.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Mastocytose systémique confirmée
- **B** Il faut trois critères mineurs en plus
- **C** Diagnostic exclu sans lésion cutanée
- **D** Une tryptase ≥ 20 µg/L est obligatoire
- **E** Leucémie à mastocytes d'emblée

Q77 **AP** **DX.11 · tryptase sous 20** Évaluation / diagnostic · policlinique

Une femme de 49 ans a fait une anaphylaxie sévère au venin d'abeille, sans urticaire. Tryptase basale : 9 µg/L. Aucune lésion cutanée.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Mastocytose exclue
- **B** Biopsie cutanée
- **C** KIT D816V dans le sang
- **D** 5-HIAA urinaire
- **E** Aucun bilan, trousse seule

Q78 **AP** **DX.12 · calcitonine faussement élevée** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 68 ans sous IPP au long cours, DFGe 35 mL/min/1,73 m², a une calcitonine légèrement élevée découverte lors d'un bilan. Pas de nodule palpable.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Thyroïdectomie totale
- **B** Sélpercatinib
- **C** Iode radioactif
- **D** Refaire et chercher une cause non tumorale
- **E** Conclure au carcinome médullaire et adresser au chirurgien

Q79 **AP** **DX.12 · lévothyroxine** Prise en charge · policlinique

Après thyroïdectomie totale pour carcinome médullaire, un homme de 44 ans reçoit de la lévothyroxine. L'interne propose une dose suppressive.

Quelle cible est la plus appropriée ?

- **A** TSH supprimée
- **B** TSH > 10 mUI/L
- **C** fT4 au double de la norme
- **D** Aucune substitution
- **E** TSH normale

Q80 AP DX.7 · consigne hypothalamique Mécanismes · cabinet

Une étudiante demande pourquoi la rougeur et la chaleur apparaissent quand la fièvre « tombe ».

Quel mécanisme explique le mieux ce flush ?

A Vasodilatation pour dissiper la chaleur

B Libération d'histamine par les mastocytes cutanés

C Excès de catécholamines

D Accumulation d'acétaldéhyde

E Sécrétion de calcitonine

🚩 Pièges & alarmes · 18 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Tryptase avant l'adrénaline, bêtabloquant seul, FSH isolée, banane et noix avant le 5-HIAA, disulfirame contre le flush, iode radioactif dans le carcinome médullaire, tibolone après cancer du sein, paroxétine sous tamoxifène, métamizole, doses spécialisées.

Q81 EX DX.8 · attendre la tryptase Prise en charge · urgences

Une femme de 22 ans a une urticaire, un œdème de la langue et une PA à 82/50 mmHg après un antibiotique. L'interne veut prélever la tryptase avant d'injecter.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Adrénaline i.m. immédiate, tryptase ensuite

B Tryptase, puis adrénaline selon le résultat

C Antihistaminique d'abord, adrénaline si échec

D Corticoïde i.v. et observation

E Test de provocation

Q82 **EX** **DX.10 · bêtabloquant seul** Prise en charge · cabinet **question négative**

Un homme de 39 ans a des crises de palpitations, sueurs et céphalées avec PA à 200/110 mmHg pendant les crises. Les métanéphrines sont en cours.

Quel médicament est contre-indiqué en monothérapie ?

- **A** Urapidil
- **B** Doxazosine
- **C** Propranolol
- **D** Nitroprussiate
- **E** Soluté salé isotonique

Q83 **AP** **DX.1 · FSH piège** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 50 ans a des bouffées typiques. Sa FSH, dosée par un autre médecin, est normale. TSH normale, examen normal.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Ménopause exclue par la FSH normale
- **B** Bouffées de la ménopause probables
- **C** Phéochromocytome à rechercher
- **D** Carcinoïde à rechercher
- **E** Répéter la FSH chaque semaine

Q84 **EX** **DX.9 · banane et noix** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 60 ans doit recueillir ses urines de 24 heures pour un 5-HIAA. Il mange chaque jour des bananes et des noix.

Quelle consigne est la plus appropriée ?

- **A** Régime sans sérotonine 72 h avant
- **B** Aucune consigne alimentaire
- **C** Jeûne complet de 24 heures
- **D** Arrêt des bananes seulement le jour même
- **E** Doubler les noix pour stimuler la sécrétion

Q85 **EX** **DX.5 · disulfirame contre le flush** Prise en charge · cabinet **question négative**

Un homme de 36 ans avec flush à l'alcool demande un médicament pour « bloquer » le flush.

Quel médicament est contre-indiqué dans ce but ?

- **A** Paracétamol
- **B** Disulfirame
- **C** Cétirizine
- **D** Oméprazole
- **E** Vitamine B1

Q86 **AP** **DX.12 · iode radioactif** Prise en charge · policlinique

Après thyroïdectomie pour carcinome médullaire, la calcitonine reste élevée. Un médecin propose de l'iode radioactif.

Quel est l'argument le plus juste ?

- **A** L'iode est réservé aux femmes
- **B** L'iode est efficace après un curage ganglionnaire central
- **C** L'iode remplace la chirurgie
- **D** L'iode guérit la forme héréditaire
- **E** Les cellules C ne fixent pas l'iode

Q87 **SPE · Gynécologie** **DX.1 · tibolone** Prise en charge · cabinet

Une femme de 57 ans traitée pour un cancer du sein il y a 5 ans demande la tibolone pour des bouffées sévères.

Quelle réponse est la plus appropriée ?

- **A** Oui, sans progestatif
- **B** Oui, à demi-dose
- **C** Oui, si la FSH est élevée
- **D** Oui, après 5 ans de rémission
- **E** Non : récidive accrue

Q88 **SPE · Dermatologie** **DX.2 · doxycycline 40 mg** Mécanismes · cabinet

Une femme de 50 ans avec rosacée papulopustuleuse reçoit de la doxycycline 40 mg à libération modifiée. Elle craint une résistance bactérienne.

Quelle explication est la plus appropriée ?

- **A** Dose anti-inflammatoire, sous le seuil antimicrobien
- **B** Dose antibiotique pleine
- **C** Action antiparasitaire sur les acariens Demodex de la peau
- **D** Agonisme alpha-2 vasoconstricteur
- **E** Action rétinoïde

Q89 **SPE · Psychiatrie** **DX.3 · escitalopram** Prise en charge · cabinet

Un homme de 32 ans a un trouble panique avec bouffées de chaleur, après bilan somatique normal. Vous débutez l'escitalopram en plus de la TCC.

Quelle posologie de départ est la plus appropriée ?

- **A** 20 mg dès le premier jour
- **B** 40 mg par jour
- **C** 10 mg un jour sur deux
- **D** Lorazépam à la place, au long cours
- **E** 5 mg la 1re semaine, puis 10 mg

Q90 SPE · Endocrinologie DX.4 · iode et orbitopathie Prise en charge · policlinique

question négative

Une femme de 45 ans a une maladie de Basedow avec orbitopathie active modérée, après rechute sous thionamide. On discute le traitement définitif.

Quelle option est contre-indiquée ?

A Thyroïdectomie totale

B Reprise du thionamide

C Avis ophtalmologique spécialisé

D Iode radioactif

E Arrêt du tabac

Q91 SPE · Hématologie DX.5 · douleur à l'alcool Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 28 ans décrit une douleur dans les ganglions du cou après chaque verre d'alcool, sans flush. Il a des adénopathies cervicales de 2 cm.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Imagerie et avis hématologique

B Test génétique ALDH2

C Rassurer : intolérance à l'alcool

D Antihistaminique avant l'alcool

E Disulfirame

Q92 **SPE · Oncologie** **DX.6 · tamoxifène et paroxétine** Prise en charge · policlinique

Une femme de 47 ans sous tamoxifène adjuvant a des bouffées gênantes. Son médecin propose la paroxétine.

Quelle réponse est la plus appropriée ?

- **A** Paroxétine 20 mg le matin, sans réserve
- **B** Arrêter le tamoxifène
- **C** Ajouter un estradiol
- **D** Doubler le tamoxifène
- **E** Éviter : baisse de l'endoxifène

Q93 **SPE · Médecine interne** **DX.7 · métamizole** Prise en charge · hôpital

Un homme de 70 ans fébrile reçoit du métamizole depuis 10 jours. Il a une nouvelle angine et une fièvre persistante.

Quel examen est le plus approprié en urgence ?

- **A** Radiographie du thorax seule
- **B** Hémocultures seules, métamizole poursuivi
- **C** CRP seule
- **D** Formule sanguine
- **E** Échocardiographie

Q94 SPE · Oncologie DX.9 · vésicule Prise en charge · policlinique

Un homme de 62 ans va débuter un analogue de la somatostatine pour un syndrome carcinoïde.

Quel examen faut-il avant le début ?

A Scintigraphie à l'iode 131

B Spirométrie

C Échographie de la vésicule biliaire

D Densitométrie osseuse de la hanche et du rachis

E EEG

Q95 SPE · Endocrinologie DX.10 · génétique Prise en charge · policlinique

Un homme de 34 ans est opéré d'un phéochromocytome sporadique apparent, sans antécédent familial.

Quelle mesure est la plus appropriée ?

A Aucun test sans antécédent familial

B Test seulement en cas de récidive

C Surveillance de 1 an puis arrêt

D Test génétique proposé

E Scanner annuel des apparentés

Q96 **SPE · Hématologie** **DX.11 · avapritinib indolent** Prise en charge · hôpital

Une femme de 51 ans a une mastocytose systémique indolente avec symptômes sévères non contrôlés malgré antihistaminiques. Plaquettes 210 G/L.

Quelle posologie d'avapritinib est la plus appropriée ?

- **A** 200 mg par jour
- **B** 300 mg par jour
- **C** 100 mg deux fois par jour
- **D** 25 mg par jour, à jeun
- **E** 25 mg deux fois par jour

Q97 **SPE · Hématologie** **DX.11 · midostaurine** Prise en charge · hôpital

Un homme de 66 ans a une mastocytose systémique agressive avec cytopénies. L'hématologue choisit la midostaurine.

Quelle posologie est la plus appropriée ?

- **A** 25 mg une fois par jour
- **B** 100 mg deux fois par jour
- **C** 50 mg deux fois par jour
- **D** 200 mg une fois par jour
- **E** 300 mg une fois par jour, à jeun le matin

Q98 SPE · Oncologie DX.12 · sélpercatinib Prise en charge · hôpital

Un homme de 58 ans, 72 kg, a un carcinome médullaire métastatique progressif avec mutation RET.

Quelle posologie de sélpercatinib est la plus appropriée ?

- **A** 120 mg deux fois par jour
- **B** 300 mg une fois par jour
- **C** 160 mg deux fois par jour
- **D** 25 mg une fois par jour
- **E** 160 mg une fois par semaine

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
Hypotension, œdème laryngé, urticaire après exposition	DX.8 : adrénaline 0,3 mg i.m. à la cuisse, 144, tryptase ensuite, observation (biphasique)
Hypertension paroxystique, céphalées, sueurs	DX.10 : métanéphrines plasmatiques libres ; alphabloquant avant bêtabloquant ; pas de glucagon
Flush sec, diarrhée aqueuse, sifflements	DX.9 : 5-HIAA urinaire 24 h, imagerie ; NT-proBNP et échocardiographie
Fièvre avec frissons ou confusion	DX.7 : hémocultures, antibiotiques en 1 h
Tachycardie, thermophobie, goitre, TSH basse	DX.4 : fT4, fT3, thyréostatique ; orage → soins intensifs
Masse cervicale dure, diarrhée, calcitonine élevée	DX.12 : échographie, test RET, métanéphrines avant chirurgie
Flush sec, urticaire pigmentaire, tryptase > 20 µg/L	DX.11 : biopsie de moelle, KIT D816V ; deux autoinjecteurs
Flush à la prise d'un médicament	DX.6 : réduire ou arrêter ; red man → débit ≤ 10 mg/min
Flush quelques minutes après l'alcool	DX.5 : éviter l'alcool ; disulfirame et métronidazole en cause ?
Flush humide, femme 45–55 ans, cycles irréguliers	DX.1 : clinique sans dosage ; THM ou fézolinétant ; < 40 ans → FSH et estradiol

Érythème centrofacial persistant, papulopustules	DX.2 : brimonidine (érythème), ivermectine (papulopustules) ; œil douloureux → ophtalmologue
Épisodes liés à la peur, examen et bilan normaux	DX.3 : TCC ; ECG et troponine si douleur thoracique

Source : Phase A · §10 Arbre décisionnel et §4 Démarche diagnostique.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 **EX** **DX.8 · flush et hypotension**

✅ **C** — Adrénaline 0,3 mg i.m. à la cuisse

① **Pourquoi c'est juste** Peau atteinte avec atteinte respiratoire et hypotension après un allergène : anaphylaxie (DX.8, 🚩 E1). L'adrénaline intramusculaire à la face antérolatérale de la cuisse, 0,3 mg chez l'adulte, précède tout bilan ; on appelle le 144 et on couche la patiente.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antihistaminique ne traite que la peau ; il est de seconde ligne.
- **B** La tryptase se prélève dans les heures suivantes ; elle ne retarde jamais l'adrénaline.
- **D** Le corticoïde n'agit pas en minutes ; seconde ligne.
- **E** Il ne corrige ni l'hypotension ni l'œdème.

③ **Perle** Deuxième dose possible 5 à 15 minutes plus tard si l'état ne s'améliore pas.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge (urgences) · LOT_007 audité

Q2 **EX** **DX.8 · position**

✅ **A** — Rester couché, jambes surélevées

① **Pourquoi c'est juste** Dans l'anaphylaxie, le décubitus jambes surélevées soutient le retour veineux et la tension (DX.8). On assoit seulement en cas de détresse respiratoire, on met en position latérale en cas de vomissements ou d'inconscience, en décubitus latéral gauche pendant la grossesse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Faire lever le patient expose à l'arrêt circulatoire, cœur vide.
- **C** Elle est réservée à la détresse respiratoire dominante.
- **D** La position debout chute le retour veineux.
- **E** Elle n'a aucun intérêt et gêne la surveillance.

③ **Perle** Ne jamais faire lever un patient anaphylactique : risque d'arrêt « cœur vide ».

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge (urgences) · LOT_007 audité

Q3 **EX** **DX.8 · surveillance**

✅ **C** — Observation prolongée de plusieurs heures

① **Pourquoi c'est juste** La moitié des réactions biphasiques survient dans les 6 à 12 heures : l'observation prolongée est justifiée (DX.8). À la sortie : deux autoinjecteurs, un plan d'action écrit, l'enseignement du geste et une consultation d'allergologie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La réaction biphasique survient souvent dans les 6 à 12 heures.
- **B** Le corticoïde ne prévient pas de façon fiable la réaction biphasique.
- **D** Durée sans justification si l'état est stable.
- **E** Le bilan allergologique se fait à distance.

③ **Perle** Tryptase de crise entre 15 minutes et 3 heures, puis tryptase basale après 24 heures.

④ **Source** Phase B DX.8 §11 · LOT_007 audité

Q4 **EX** **DX.10 vs DX.3 · crise paroxystique**

✅ **E** — Métanéphrines plasmatiques libres

① **Pourquoi c'est juste** Triade céphalées, palpitations, sueurs avec hypertension paroxystique : phéochromocytome jusqu'à preuve du contraire (DX.10, 🚩 E3). Les métanéphrines plasmatiques libres sont le premier examen (CHUV, OPAS) ; la tension peut être normale entre les crises.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie suit une biochimie positive.
- **B** Il cible le syndrome carcinoïde, flush sec avec diarrhée.
- **C** Elle cible la mastocytose.
- **D** Une hypertension paroxystique impose d'exclure le phéochromocytome avant la panique.

③ **Perle** Métanéphrines plasmatiques libres : sensibilité 99 %, spécificité 89 %.

④ **Source** Phase B DX.10 §9 · LOT_007 audité

Q5 EX DX.10 · alpha avant bêta

✅ **B** — Alphabloquant d'abord, bêtabloquant ensuite

① **Pourquoi c'est juste** Dans le phéochromocytome, l'alphabloquant précède toujours le bêtabloquant (DX.10). L'AIPS du propranolol précise « seulement en association avec un alphabloquant » ; le bêta-blocage seul peut aggraver la crise.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le bêtabloquant seul laisse l'effet alpha sans opposition : crise hypertensive.
- **C** Le glucagon libère des catécholamines ; il est contre-indiqué.
- **D** L'opération se fait après le blocage alpha.
- **E** La patiente a un volume plasmatique réduit.

③ **Perle** Le bêtabloquant n'est ajouté que si la tachycardie persiste après l'alpha-blocage.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_007 audité

Q6 EX DX.10 · crise hypertensive

✅ **A** — Urapidil i.v. 10 à 50 mg, patient couché

① **Pourquoi c'est juste** Crise catécholaminergique : patient couché, scope, voie veineuse, puis urapidil i.v. 10 à 50 mg ; la baisse de tension est attendue en 5 minutes (AIPS Ebrantil®) (DX.10). Si la tension reste élevée : perfusion d'urapidil ou nitroprussiate.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Aucun bêtabloquant avant l'alpha-blocage.
- **C** Une crise catécholaminergique se traite sous monitorage, à l'hôpital.
- **D** Le glucagon déclenche une crise hypertensive dans le phéochromocytome.
- **E** Risque d'accident vasculaire cérébral.

③ **Perle** Après la crise : doser les métanéphrines, débuter l'alpha-blocage oral, planifier l'imagerie.

④ **Source** Phase B DX.10 §11 · LOT_007 audité

Q7 EX DX.7 · flush fébrile grave

✅ **D** — Hémocultures et antibiotique dans l'heure

① **Pourquoi c'est juste** Flush avec fièvre, confusion, polypnée et hypotension : qSOFA à 3, sepsis probable (DX.7, 🚩 E2). Hémocultures et lactate, antibiotique dans l'heure, remplissage vasculaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antipyrétique ne traite pas le sepsis.
- **B** Le flush accompagne ici une infection grave.
- **C** L'antibiotique ne doit pas attendre la culture.
- **E** Pas d'urticaire ni d'allergène : rien n'évoque l'anaphylaxie.

③ **Perle** Le qSOFA dépiste (FR ≥ 22/min, conscience altérée, PAS ≤ 100 mmHg) ; il ne pose pas le diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_007 audité

Q8 EX DX.7 · hyperthermie

✅ **B** — Refroidissement externe immédiat

① **Pourquoi c'est juste** Température élevée sans réponse au paracétamol, avec chaleur et neuroleptique : hyperthermie non pyrogène, la consigne hypothalamique est normale (DX.7). On refroidit immédiatement et on cherche la cause.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La consigne hypothalamique est normale : l'antipyrétique n'agit pas.
- **C** Antipyrétique inefficace dans l'hyperthermie, et risque d'agranulocytose.
- **D** Le refroidissement passe avant le bilan.
- **E** Aucun antipyrétique n'agit sur une hyperthermie.

③ **Perle** Fièvre = consigne relevée par la PGE2 ; hyperthermie = consigne normale débordée.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_007 audité

Q9 **EX** **DX.4 · orage thyréotoxique**

✅ **A** — Soins intensifs, thyréostatique et bêtabloquant

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre, agitation, tachycardie extrême chez une hyperthyroïdienne : crise thyrotoxique (DX.4, 🚩 E4). Soins intensifs, thyréostatique à forte dose, propranolol 10 à 40 mg 3 à 4 fois par jour en l'absence d'asthme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il ne s'utilise pas en phase aiguë.
- **C** Mortalité élevée sans soins intensifs.
- **D** Le traitement ne doit pas attendre l'imagerie.
- **E** Le traitement initial est médical.

③ **Perle** Le score de Burch et Wartofsky ou de la JTA aide à reconnaître la crise.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge (urgences) · LOT_007 audité

Q10 **EX** **DX.9 · flush sec et diarrhée**

✅ **C** — 5-HIAA urinaire des 24 heures

① **Pourquoi c'est juste** Flush sec avec diarrhée sécrétoire, sibilants et hépatomégalie nodulaire : syndrome carcinoïde (DX.9, 🚩 E5). Le 5-HIAA urinaire des 24 heures confirme, au-delà de 50 µmol/24 h, avec une tumeur identifiée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elles ciblent le phéochromocytome, flush humide avec hypertension.
- **B** Elle est élevée dans les TNE avec ou sans syndrome.
- **D** Elle cible le carcinome médullaire, avec nodule thyroïdien.
- **E** Hors sujet chez un homme ; flush sec avec diarrhée.

③ **Perle** Le syndrome n'apparaît que lorsque les médiateurs échappent au foie, le plus souvent par des métastases hépatiques.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_007 audité

Q11 **EX** **DX.9 · bilan cardiaque**

✅ **D** — NT-proBNP et échocardiographie

① **Pourquoi c'est juste** Tout patient avec 5-HIAA élevé reçoit un NT-proBNP et une échocardiographie : l'examen du cœur seul est peu fiable (DX.9). Un 5-HIAA supérieur à 300 µmol/24 h impose l'échocardiographie d'emblée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'examen du cœur seul est peu fiable.
- **B** La cardiopathie carcinoïde est valvulaire droite, pas coronarienne.
- **C** Il ne détecte pas l'atteinte valvulaire.
- **E** Elle ne montre pas la fibrose valvulaire.

③ **Perle** NT-proBNP < 260 pg/mL : valeur prédictive négative de 97 % pour la cardiopathie.

④ **Source** Phase B DX.9 §10 · LOT_007 audité

Q12 **EX** **DX.9 · avant anesthésie**

✅ **B** — Octréotide i.v. préparé, sans sympathomimétique

① **Pourquoi c'est juste** Avant une anesthésie ou un geste invasif, on prépare l'octréotide intraveineux et on évite les sympathomimétiques pour prévenir la crise carcinoïde (DX.9). Le protocole repose sur un consensus.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les sympathomimétiques libèrent les médiateurs et aggravent la crise.
- **C** Préparation du phéochromocytome, pas du carcinoïde.
- **D** La crise carcinoïde peut survenir au bloc.
- **E** On poursuit l'analogue sans interruption.

③ **Perle** La méta-analyse de 2022 ne montre pas de baisse nette de la crise sous octréotide (RC 0,73, IC 0,32–1,66) : rester vigilant.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_007 audité

Q13 **EX** **DX.12 · avant chirurgie**

✅ **A** — Métanéphrines plasmatiques libres

① **Pourquoi c'est juste** Avant toute chirurgie d'un carcinome médullaire, on exclut un phéochromocytome associé (néoplasie endocrinienne multiple de type 2) par les métanéphrines : l'anesthésie sans alpha-blocage peut déclencher une crise (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Les cellules C ne fixent pas l'iode.
- **C** Il cible le syndrome carcinoïde.
- **D** Elle cible la mastocytose.
- **E** Sans intérêt préopératoire.

③ **Perle** Ordre : métanéphrines → alpha-blocage et surrénalectomie si positives → thyroïdectomie.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_007 audité

Q14 **EX** **DX.12 · nodule avec diarrhée**

✅ **E** — Calcitonine sérique

① **Pourquoi c'est juste** Nodule dur, adénopathie, diarrhée, flush et antécédent familial : carcinome médullaire de la thyroïde (DX.12, 🚩 E7). On dose la calcitonine et on fait une échographie ; au-delà de 100 ng/L, le diagnostic est probable.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Marqueur des cancers différenciés, pas des cellules C.
- **B** Le nodule thyroïdien oriente vers les cellules C.
- **C** Ils orientent vers une thyroïdite auto-immune.
- **D** Elle cible la mastocytose.

③ **Perle** Ne jamais opérer un nodule suspect sans calcitonine.

④ **Source** Phase B DX.12 §10 · LOT_007 audité

Q15 EX DX.11 · anaphylaxie au venin

✅ **C** — Biopsie de moelle osseuse

① **Pourquoi c'est juste** Anaphylaxie au venin sans urticaire avec tryptase basale ≥ 20 µg/L : mastocytose systémique à rechercher (DX.11, 🚩 E6). La biopsie de moelle osseuse, lue selon l'OMS 2022, est l'examen de référence.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une tryptase basale à distance reflète la charge mastocytaire.
- **B** Il ne remplace pas le bilan ni l'adrénaline.
- **D** Aucun argument thyroïdien.
- **E** Rien n'évoque un carcinoïde.

③ **Perle** Tryptase basale ≥ 20 µg/L = critère mineur, pas un diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.11 §10 · LOT_007 audité

Q16 EX DX.11 · trousse d'urgence

✅ **D** — Deux autoinjecteurs d'adrénaline

① **Pourquoi c'est juste** Premier but dans la mastocytose : éviter toute nouvelle anaphylaxie, avec une trousse d'adrénaline toujours disponible (DX.11). L'antihistaminique H1 soulage la peau mais ne remplace jamais l'adrénaline.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de la forme avancée, sans indication ici.
- **B** Aucune indication dans la forme indolente contrôlée.
- **C** L'antihistaminique ne prévient pas l'anaphylaxie.
- **E** La mastocytose expose à l'anaphylaxie.

③ **Perle** Prévenir le chirurgien et l'anesthésiste avant tout geste ; carte de patient.

④ **Source** Phase B DX.11 §11 · LOT_007 audité

Q17 **EX** **DX.1 vs DX.4 · TSH d'abord**

✅ **B** — TSH

① **Pourquoi c'est juste** Amaigrissement, palpitations et tremblement : la TSH précède toute conclusion de ménopause (DX.1, DX.4). Une TSH normale est un critère d'exclusion du diagnostic de bouffées ménopausiques.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La FSH varie en périménopause et ne pose pas le diagnostic.
- **C** Il ne change pas la décision.
- **D** Pas d'hypertension paroxystique.
- **E** Aucun saignement post-ménopausique.

③ **Perle** Une sueur avec amaigrissement, fièvre ou hypertension paroxystique n'est pas la ménopause.

④ **Source** Phase B DX.1 §13 · LOT_007 audité

Q18 **EX** **DX.1 · forme modérée**

✅ **A** — Estradiol transdermique plus progestatif

① **Pourquoi c'est juste** Bouffées modérées à sévères sans contre-indication : THM en première ligne, le plus efficace (DX.1). Estradiol (Oestrogel® 2 pressions par jour) ; utérus présent → progestatif 12 à 14 jours par mois ou en continu.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Avec un utérus, le progestatif protège l'endomètre.
- **C** Ni NICE ni l'AIPS ne la proposent d'emblée.
- **D** Usage hors AIPS, alternative au THM seulement.
- **E** Efficacité non prouvée.

③ **Perle** Le THM réduit les bouffées d'environ 75 % par rapport au placebo.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_007 audité

Q19 **EX** **DX.1 · début précoce**

✅ **E** — FSH et estradiol

① **Pourquoi c'est juste** Avant 40 ans, on cherche une insuffisance ovarienne prématurée par la FSH et l'estradiol ; on ne conclut pas à une ménopause (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On ne pose pas l'étiquette ménopause avant 40 ans sans bilan.
- **B** Indiqué chez la femme post-ménopausée, après le diagnostic.
- **C** Une insuffisance ovarienne prématurée se cherche maintenant.
- **D** Pas de triade adrénergique.

③ **Perle** Après 45 ans, tableau typique : pas de dosage hormonal ; avant 40 ans : bilan obligatoire.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_007 audité

Q20 **EX** **DX.3 · douleur thoracique**

✅ **A** — ECG et troponine

① **Pourquoi c'est juste** Une douleur thoracique impose ECG et troponine avant tout autre examen, même chez une patiente anxieuse connue (DX.3). Le flush émotionnel est un diagnostic d'exclusion.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** On n'attribue pas la crise à la panique sans exclure l'infarctus.
- **C** Ne ferme pas la branche cardiaque.
- **D** Ne répond pas à la douleur thoracique aiguë.
- **E** Différer l'évaluation cardiaque est dangereux.

③ **Perle** Antécédent psychiatrique = piège d'attribution prématurée.

④ **Source** Phase B DX.3 §10 · LOT_007 audité

Q21 EX DX.6 · red man

✅ **D** — Arrêter, puis reprendre à ≤ 10 mg/min

① **Pourquoi c'est juste** Rougeur du torse pendant une perfusion rapide de vancomycine, sans signe d'anaphylaxie : « red man », libération d'histamine dépendante du débit (DX.6). On arrête, puis on reprend à 10 mg/min au plus, en 60 minutes au moins.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de critère d'anaphylaxie : réaction liée au débit.
- **B** Ce n'est pas une allergie vraie.
- **C** Le débit trop rapide est la cause.
- **E** Sans rapport avec la réaction.

③ **Perle** La réaction régresse 20 minutes à 2 heures après l'arrêt de la perfusion.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_007 audité

Q22 EX DX.6 · nitré et PDE5

✅ **B** — Allonger, remplir, surveiller monitoré

① **Pourquoi c'est juste** Nitré et inhibiteur de la PDE5 pris ensemble avec hypotension : allonger, remplissage, surveillance monitorée, supprimer l'association (DX.6). L'association est contre-indiquée par l'AIPS.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Aggrave l'hypotension, potentiellement fatale.
- **C** Pas de tableau allergique ; cause pharmacologique.
- **D** Hypotension sévère à surveiller.
- **E** Aggraverait l'hypotension.

③ **Perle** Ne jamais associer un nitré et un inhibiteur de la PDE5.

④ **Source** Phase B DX.6 §10 · LOT_007 audité

Q23 **EX** **DX.5 vs DX.8 · alcool et stridor**

✅ **B** — Adrénaline i.m.

① **Pourquoi c'est juste** Un flush avec urticaire, stridor et hypotension est une anaphylaxie, quel que soit le déclencheur : adrénaline i.m. 0,3 mg, puis surveillance (DX.5, DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le disulfirame provoque le flush ; il ne le traite pas.
- **C** Stridor et hypotension imposent l'urgence.
- **D** Seconde ligne ; ne traite pas l'obstruction.
- **E** Sans place en urgence.

③ **Perle** Tout stridor ou hypotension pendant un flush est une urgence.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_007 audité

Q24 **EX** **DX.4 · agranulocytose**

✅ **A** — Arrêter et faire une formule sanguine

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre, angine ou aphtes sous thionamide évoquent une agranulocytose : arrêt du médicament et formule sanguine en urgence (AIPS Néo-Mercazole®) (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Ne pas méconnaître une agranulocytose.
- **C** Aggraverait une agranulocytose.
- **D** Délai dangereux.
- **E** Ne répond pas à l'urgence.

③ **Perle** Formule sanguine avant, puis chaque semaine pendant 6 semaines après 40 ans, surtout au-delà de 40 mg par jour.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_007 audité

Q25 EX DX.2 · œil douloureux

✅ **D** — Avis ophtalmologique urgent

① **Pourquoi c'est juste** Un œil rouge douloureux chez un rosacéen impose un avis ophtalmologique urgent : la kératite menace la vue (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une kératite menace la vue.
- **B** Topique de l'érythème facial, pas de l'œil.
- **C** Ne jamais prescrire avant l'examen ophtalmologique.
- **E** Sans effet sur l'atteinte oculaire.

③ **Perle** L'atteinte oculaire est un phénotype majeur de la rosacée.

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_007 audité

Q26 SPE · Anesthésiologie DX.10 · crise peropératoire

✅ **B** — Nitroprussiate i.v. à 0,2 µg/kg/min

① **Pourquoi c'est juste** Pic hypertensif peropératoire : arrêter la manipulation si possible, puis vasodilatateur de courte durée, nitroprussiate débuté à 0,2 µg/kg/min et doublé toutes les 3 à 5 minutes, ou urapidil en injection (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Bêtabloquant seulement si la tachycardie persiste après l'alpha-blocage.
- **C** Contre-indiqué : libère des catécholamines.
- **D** Vasopresseur : aggrave l'hypertension.
- **E** On arrête la manipulation et on traite le pic.

③ **Perle** Après la ligature de la veine surrénalienne, le risque devient l'hypotension (volume plasmatique réduit).

④ **Source** Phase B DX.10 §11 · LOT_007 audité

Q27 **SPE · Anesthésiologie** **DX.9 · hypotension au bloc**

✅ **C** — Phényléphrine ou vasopressine

① **Pourquoi c'est juste** Crise carcinoïde avec hypotension persistante : phényléphrine ou vasopressine, car les sympathomimétiques classiques aggravent la libération des médiateurs (DX.9). L'octréotide i.v. est poursuivi.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les sympathomimétiques classiques libèrent les médiateurs.
- **B** Sympathomimétique : aggrave la crise.
- **D** Sympathomimétique, sans effet vasoconstricteur utile.
- **E** Sympathomimétique bêta : vasodilatation.

③ **Perle** Bronchospasme carcinoïde : éviter aussi les sympathomimétiques ; traitement guidé par l'anesthésiste.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_007 audité

Q28 **SPE · Endocrinologie** **DX.12 · hypocalcémie postopératoire**

✅ **B** — Calcium i.v. lent sous scope

① **Pourquoi c'est juste** Hypocalcémie aiguë après thyroïdectomie : ECG, scope, voie veineuse, calcémie ionisée, magnésium et PTH, puis calcium i.v. lent (DX.12). Relais : calcitriol 0,25 µg par jour et calcium oral.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans rapport avec la tétanie.
- **C** Le relais oral suit le calcium i.v.
- **D** Aggraverait l'hypocalcémie.
- **E** L'hypocalcémie se corrige médicalement.

③ **Perle** Calcémie deux fois par semaine au début sous calcitriol ; arrêt si dépassement de la norme.

④ **Source** Phase B DX.12 §11 · LOT_007 audité

Q29 AP DX.7 · fièvre inexpliquée

✅ **D** — PET-TDM

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre ≥ 38,3 °C à plus de 3 reprises pendant plus de 3 semaines, sans explication après un bilan minimal : fièvre prolongée inexpliquée (Delphi 2024) (DX.7). Le PET-TDM suit, puis la biopsie du site actif.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Masque le diagnostic d'une FPI.
- **B** Peut masquer un lymphome ou une infection.
- **C** Hors sujet chez un homme fébrile.
- **E** Retard diagnostique.

③ **Perle** Une fièvre objective exclut le diagnostic de bouffées ménopausiques.

④ **Source** Phase B DX.7 §10 · LOT_007 audité

Q30 SPE · Médecine intensive DX.8 · choc réfractaire

✅ **C** — Adrénaline i.v. titrée en soins monitorés

① **Pourquoi c'est juste** Choc anaphylactique réfractaire à l'adrénaline i.m. : adrénaline intraveineuse en soins monitorés, 0,05 à 0,1 mg répétable toutes les 3 à 5 minutes (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Seconde ligne, sans effet hémodynamique.
- **B** N'agit pas en minutes.
- **D** Ne guide pas l'urgence.
- **E** Aggrave le retour veineux.

③ **Perle** Le glucagon est cité sous bêtabloquant, avec des preuves très limitées.

④ **Source** Phase B DX.8 §11 · LOT_007 audité

Q31 **EX** **DX.1 · diagnostic clinique**

✅ **E** — Diagnostic clinique, sans dosage

① **Pourquoi c'est juste** Femme de 40 à 65 ans, bouffées humides récurrentes, température et TSH normales, sans drapeau rouge : bouffées de la ménopause, diagnostic clinique (NAMS 2022–2023) (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La FSH varie d'un jour à l'autre en périménopause.
- **B** Aucun dosage ne pose le diagnostic.
- **C** Flush humide, sans diarrhée.
- **D** Sans urticaire ni anaphylaxie.

③ **Perle** Après 45 ans, tableau typique : pas de FSH.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_007 audité

Q32 **EX** **DX.1 · voie non hormonale**

✅ **B** — Fézolinétant 45 mg par jour

① **Pourquoi c'est juste** Après cancer du sein, le THM est contre-indiqué : option non hormonale, fézolinétant (VEOZA™) 45 mg une fois par jour, antagoniste NK3 (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué après cancer du sein.
- **C** Récidive accrue après cancer du sein.
- **D** THM contre-indiqué après cancer du sein.
- **E** Non proposée d'emblée ; hors AIPS.

③ **Perle** Bilan hépatique avant, puis chaque mois pendant 3 mois ; réévaluation à 12 mois.

④ **Source** Phase B DX.1 §10 · LOT_007 audité

Q33 **EX** **DX.1 · surveillance VEOZA**

✅ **B** — Bilan hépatique avant, puis mensuel

① **Pourquoi c'est juste** VEOZA™ exige ALAT, ASAT, PAL et bilirubine avant le début, puis chaque mois pendant 3 mois (AIPS) (DX.1). On ne débute pas si ALAT ou ASAT > 2 × LSN.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le suivi AIPS est hépatique.
- **C** Inutile.
- **D** Suivi du carbimazole, pas du fézolinétant.
- **E** Sans rapport avec ce médicament.

③ **Perle** Arrêt si transaminases > 5 × LSN, ou > 3 × LSN avec bilirubine > 2 × LSN.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_007 audité

Q34 **EX** **DX.2 vs DX.1 · rougeur persistante**

✅ **D** — Rosacée

① **Pourquoi c'est juste** Rougeur centrofaciale persistante avec poussées : phénotype diagnostique de rosacée, qui suffit seul (NRS 2017, ROSCO 2019) (DX.2). Les comédons orientent vers l'acné.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'examen est normal entre les épisodes dans la ménopause.
- **B** Les comédons manquent.
- **C** Pas de signe de Darier ni d'urticaire.
- **E** Pas de diarrhée ; rougeur persistante.

③ **Perle** Rosacée : 5,46 % en population générale (méta-analyse 2018).

④ **Source** Phase B DX.2 §8 · LOT_007 audité

Q35 **EX** **DX.2 · papulopustules**

✅ **A** — Ivermectine crème 1 g par jour

① **Pourquoi c'est juste** Rosacée papulopustuleuse moyennement sévère à sévère : ivermectine (Soolantra®) 1 g de crème une fois par jour, jusqu'à 3 mois (AIPS) (DX.2). Évaluation à 3 mois ; arrêt sans amélioration.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Elle traite l'érythème, pas les lésions inflammatoires.
- **C** Il provoque une dermatose rosacéiforme.
- **D** La rosacée n'est pas une indication AIPS.
- **E** L'AIPS ne retient que l'acné.

③ **Perle** Soolantra® pour les papulopustules, Mirvaso® pour l'érythème.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_007 audité

Q36 **EX** **DX.2 · érythème**

✅ **D** — Brimonidine gel une fois par jour

① **Pourquoi c'est juste** Érythème facial de la rosacée : brimonidine (Mirvaso®), un petit pois sur chacune des 5 zones du visage, une fois par jour, maximum 1 g (AIPS) (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Cible les papulopustules.
- **B** Induit une dermatose rosacéiforme.
- **C** Sans indication dans l'érythème rosacéen.
- **E** Dose antibiotique, sans intérêt pour l'érythème seul.

③ **Perle** Rebond de l'érythème possible, plus sévère, surtout les 2 premières semaines.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_007 audité

Q37 EX DX.3 · diagnostic d'exclusion

✅ **C** — Flush émotionnel

① **Pourquoi c'est juste** Rougeur liée à la peur du jugement avec évitement, examen et TSH normaux : flush émotionnel sur anxiété sociale (DX.3), diagnostic d'exclusion après élimination des causes organiques.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas d'hypertension paroxystique ni de céphalées.
- **B** TSH normale.
- **D** Pas de diarrhée ni de sifflements.
- **E** Pas de rougeur persistante ni de papulopustules.

③ **Perle** Anxiété : 14,0 % sur 12 mois en Europe (UE-27, Suisse, 2011).

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_007 audité

Q38 EX DX.3 · traitement de fond

✅ **A** — Psychothérapie cognitivo-comportementale

① **Pourquoi c'est juste** La TCC est le traitement de première intention des troubles anxieux (DX.3) ; l'escitalopram (Cipralex®) 10 mg par jour peut s'y ajouter.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Les benzodiazépines servent brièvement, pas en fond.
- **C** Il ne traite que les symptômes somatiques.
- **D** Indiqué dans les bouffées de la ménopause.
- **E** Traitement de la rosacée.

③ **Perle** Lorazépam : durée la plus brève possible, généralement pas plus de 2 à 3 mois (AIPS).

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_007 audité

Q39 **EX** **DX.3 vs DX.4 · anxieux avec TSH basse**

✅ **E** — Hyperthyroïdie

① **Pourquoi c'est juste** TSH supprimée avec fT4 élevée : hyperthyroïdie franche (DX.3, DX.4). L'anxiété est un symptôme de thyrotoxicose, non une cause à traiter seule.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'anxiété est ici un symptôme de thyrotoxicose.
- **B** La TSH basse oriente vers une cause organique.
- **C** Âge et biologie incompatibles.
- **D** Aucun médicament en cause.

③ **Perle** Toujours doser TSH et fT4 chez un patient qui rougit et qui est anxieux.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_007 audité

Q40 **EX** **DX.4 · diagnostic biologique**

✅ **D** — fT4 et T3

① **Pourquoi c'est juste** Une TSH basse isolée ne suffit pas : la fT4 et la T3 élevées posent l'hyperthyroïdie franche ; fT4 et T3 normales définissent la forme subclinique (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle cherche la cause, après la confirmation.
- **B** Ils ne confirment pas l'hyperthyroïdie.
- **C** Elle cible le carcinome médullaire.
- **E** Retard ; on complète d'emblée par fT4 et T3.

③ **Perle** Ensuite : TSH-R-Ab, échographie, scintigraphie pour la cause.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_007 audité

Q41 EX DX.4 · grossesse

✅ **E** — Propylthiouracile

① **Pourquoi c'est juste** Au 1er trimestre, le propylthiouracile est préféré, car le carbimazole est plus tératogène ; ensuite on revient au carbimazole, car le propylthiouracile est hépatotoxique (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Plus tératogène au 1er trimestre.
- **B** Contre-indiqué pendant la grossesse.
- **C** Ne traite pas la cause.
- **D** Aggraverait la thyrotoxicose.

③ **Perle** Avis d'endocrinologie ; contraception fiable sous carbimazole.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_007 audité

Q42 EX DX.4 · TSH normale

✅ **B** — Hyperthyroïdie exclue

① **Pourquoi c'est juste** Une TSH normale exclut l'hyperthyroïdie ; on cherche alors DX.1 à DX.3 et les autres causes de flush (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** TSH normale : hyperthyroïdie exclue.
- **C** Sans indication.
- **D** Aucune base biologique.
- **E** Sans indication.

③ **Perle** TSH normale = critère d'exclusion respecté pour poser le diagnostic de ménopause.

④ **Source** Phase B DX.4 §10 · LOT_007 audité

Q43 **EX** **DX.5 · déficit en ALDH2**

✅ **B** — Déficit en ALDH2

① **Pourquoi c'est juste** Flush reproductible 5 à 10 minutes après l'alcool, origine d'Asie de l'Est, sans flush spontané : déficit en ALDH2 (DX.5). L'acétaldéhyde s'accumule.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il donne des flushs spontanés avec diarrhée.
- **C** Flushs aussi sans alcool, prurit.
- **D** Rougeur persistante entre les épisodes.
- **E** Crises hypertensives sans lien avec l'alcool.

③ **Perle** Questionnaire à deux questions : environ 90 % de sensibilité et de spécificité.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_007 audité

Q44 **EX** **DX.5 · métronidazole**

✅ **C** — Aucun alcool pendant et le jour suivant

① **Pourquoi c'est juste** Sous métronidazole, aucun alcool pendant le traitement et le jour suivant (AIPS Flagyl®) (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une réaction de type disulfirame est possible.
- **B** La consigne couvre tout le traitement.
- **D** Interrompre le traitement est inutile.
- **E** Ne prévient pas la réaction.

③ **Perle** Disulfirame et métronidazole bloquent la dégradation de l'acétaldéhyde.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_007 audité

Q45 **EX** **DX.5 · sous disulfirame**

✅ **A** — Réaction possible jusqu'à 3 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Après l'arrêt d'Antabus®, la réaction reste possible jusqu'à trois semaines ; l'enzyme repousse en une semaine ou plus (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'enzyme repousse en une semaine ou plus.
- **C** La réaction reste possible plus longtemps.
- **D** Toute quantité peut déclencher la réaction.
- **E** Le risque persiste après l'arrêt.

③ **Perle** Sous disulfirame, même l'alcool caché (médicaments, aliments) provoque un flush.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_007 audité

Q46 **EX** **DX.6 · inhibiteur calcique**

✅ **B** — Flush médicamenteux

① **Pourquoi c'est juste** Flush apparu après l'introduction d'un vasodilatateur : flush médicamenteux ; la rougeur du visage est un effet indésirable fréquent de l'amlodipine (AIPS) (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le lien chronologique avec le médicament prime.
- **C** PA contrôlée, sans triade.
- **D** Pas de rougeur persistante ni de papules.
- **E** Ni urticaire ni hypotension.

③ **Perle** Le flush s'atténue souvent en quelques semaines ; ne pas arrêter un inhibiteur calcique sans avis.

④ **Source** Phase B DX.6 §8 · LOT_007 audité

Q47 **EX** **DX.6 · persistance**

✅ **A** — 5-HIAA urinaire des 24 heures

① **Pourquoi c'est juste** Un flush qui persiste à l'arrêt du médicament impose de chercher carcinoïde, mastocytose ou phéochromocytome (DX.6, DX.9) ; avec des selles liquides, le 5-HIAA des 24 h.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un flush persistant à l'arrêt fait chercher une autre cause.
- **C** Ne traite pas un flush d'autre cause.
- **D** Retard d'un carcinoïde possible.
- **E** Hors sujet.

③ **Perle** La régression à l'arrêt est le critère d'imputabilité le plus fort.

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_007 audité

Q48 **EX** **DX.7 · seuil de fièvre**

✅ **C** — Température centrale mesurée ≥ 38,0 °C

① **Pourquoi c'est juste** La fièvre se prouve par la température centrale mesurée (≥ 38,3 °C selon les sociétés, 38,0 °C en usage clinique) ; le flush seul ne suffit pas (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le flush seul ne suffit pas à poser la fièvre.
- **B** Signe de flush, non de fièvre.
- **D** Nombreuses causes.
- **E** Mesure périphérique peu fiable.

③ **Perle** Piège : confondre fièvre et bouffée ménopausique.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_007 audité

Q49 **EX** **DX.7 · dose de paracétamol**

✅ **B** — 1 g toutes les 6 h, max 4 g/j

① **Pourquoi c'est juste** Paracétamol (Dafalgan®) adulte > 40 kg : 500 à 1 000 mg par prise, intervalle de 4 à 8 heures, maximum 4 g par jour (AIPS) (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dépasse la dose maximale.
- **C** Intervalle trop court.
- **D** Sous-dosé.
- **E** Dépasse 4 g par jour.

③ **Perle** 3 g/j si clairance 10–50 mL/min ; 2 g/j si < 10 mL/min.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_007 audité

Q50 **EX** **DX.8 · hypotension sans peau**

✅ **D** — Anaphylaxie

① **Pourquoi c'est juste** L'hypotension après un allergène connu suffit à poser l'anaphylaxie, même sans atteinte cutanée (critère 2, WAO 2020) (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Hypotension après un allergène connu : anaphylaxie jusqu'à preuve du contraire.
- **B** Absente.
- **C** Diagnostic d'exclusion.
- **E** N'explique pas l'hypotension.

③ **Perle** Hypotension adulte : PAS < 90 mmHg ou baisse > 30 %.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_007 audité

Q51 **EX** **DX.8 · urticaire chronique**

✅ **A** — Antihistaminique H1 de 2e génération

① **Pourquoi c'est juste** Urticaire chronique spontanée (> 6 semaines) : antihistaminique H1 de 2e génération pris chaque jour, augmentable jusqu'à 4 fois la dose, puis omalizumab (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Seulement en cure courte pour une poussée.
- **C** Après échec des antihistaminiques.
- **D** Il se prend chaque jour.
- **E** Sans anaphylaxie, ne traite pas l'urticaire.

③ **Perle** Une papule dure de 30 minutes à 24 heures ; au-delà, penser vasculite urticarienne.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_007 audité

Q52 **EX** **DX.9 vs DX.1 · sec ou humide**

✅ **C** — Syndrome carcinoïde

① **Pourquoi c'est juste** Le flush carcinoïde est sec, bref, au visage et au thorax ; associé à une diarrhée et des sifflements, il impose le 5-HIAA (DX.9). Un flush avec sueurs profuses évoque plutôt la ménopause.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Bouffée humide sans diarrhée.
- **B** Diagnostic d'exclusion.
- **D** Ne donne ni diarrhée ni sifflements.
- **E** Pas de lien avec l'alcool rapporté.

③ **Perle** Humide : ménopause, catécholamines, fièvre ; sec : carcinoïde, mastocytose, médicaments.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_007 audité

Q53 **EX** **DX.9 · première ligne**

✅ **C** — Analogue de la somatostatine

① **Pourquoi c'est juste** Les analogues de la somatostatine sont la première ligne : octréotide LAR 20 mg i.m. toutes les 4 semaines ou lanréotide 60 à 120 mg tous les 28 jours (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Effet antisécrétoire faible ; tumeur progressive.
- **B** Réservé à la tumeur progressive avec récepteurs.
- **D** S'ajoute à l'analogue, ne le remplace pas.
- **E** Symptomatique, ne contrôle pas la sécrétion.

③ **Perle** Ils améliorent les symptômes chez jusqu'à 70 % des patients.

④ **Source** Phase B DX.9 §11 · LOT_007 audité

Q54 **EX** **DX.10 · biologie avant imagerie**

✅ **D** — Métanéphrines avant tout geste

① **Pourquoi c'est juste** Avant toute biopsie ou chirurgie d'une masse surrénalienne, on dose les métanéphrines : une biopsie peut déclencher une crise (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une biopsie peut déclencher une crise.
- **B** Le blocage alpha précède l'opération si phéochromocytome.
- **C** La biochimie précède l'imagerie fonctionnelle.
- **E** Sans avoir exclu une tumeur sécrétante.

③ **Perle** L'imagerie seule ne distingue pas le phéochromocytome d'un adénome.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_007 audité

Q55 **EX** **DX.10 · glucagon**

✅ **E** — Glucose i.v.

① **Pourquoi c'est juste** Chez un diabétique hypoglycémique avec phéochromocytome suspecté, on donne du glucose et on évite le glucagon, contre-indiqué par l'AIPS (crise hypertensive) (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué : libère des catécholamines.
- **B** Sympathomimétique : risque de crise.
- **C** L'hypoglycémie se corrige sans délai.
- **D** Hors sujet.

③ **Perle** Autres déclencheurs à éviter : sympathomimétiques, efforts de poussée, palpation profonde.

④ **Source** Phase B DX.10 §10 · LOT_007 audité

Q56 **EX** **DX.11 vs DX.8 · signe de Darier**

✅ **C** — Mastocytose

① **Pourquoi c'est juste** Le signe de Darier (papule urticarienne en minutes après frottement d'une macule brunâtre) est spécifique de la mastocytose cutanée, peu sensible (DX.11, DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le dermographisme se teste en peau saine par un trait ferme.
- **B** Atteinte faciale persistante.
- **D** Pas de macules urticariennes.
- **E** Pas de lésion cutanée fixe.

③ **Perle** Frotter peu pour éviter une réaction étendue.

④ **Source** Phase A §6 Examen physique · LOT_007 audité

Q57 **EX** **DX.11 · tryptase**

✅ **B** — Biopsie de moelle osseuse

① **Pourquoi c'est juste** Tryptase basale ≥ 20 µg/L : critère mineur de mastocytose ; on demande la biopsie de moelle, avec recherche de KIT D816V (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas d'hypertension paroxystique.
- **C** Pas de nodule thyroïdien.
- **D** Retard diagnostique.
- **E** Sans rapport.

③ **Perle** Tryptase basale normale < 11,4 µg/L.

④ **Source** Phase B DX.11 §10 · LOT_007 audité

Q58 **EX** **DX.12 · RET**

✅ **E** — Test RET du patient puis des apparentés

① **Pourquoi c'est juste** Test génétique RET à tous les patients atteints de carcinome médullaire, puis dépistage des apparentés du 1er degré (DX.12). Chez l'enfant, le risque de la mutation guide la date de la thyroïdectomie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On le propose à tous les patients.
- **B** La génétique guide le dépistage.
- **C** Le test RET guide l'indication et la date.
- **D** Forme héréditaire possible.

③ **Perle** Mutation germinale = forme héréditaire (NEM 2) ; somatique = sporadique.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_007 audité

Q59 EX DX.12 · traitement curatif

✅ **E** — Thyroïdectomie totale avec curage central

① **Pourquoi c'est juste** Le traitement curatif est la thyroïdectomie totale avec curage central, en centre spécialisé, après exclusion du phéochromocytome (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les cellules C ne fixent pas l'iode.
- **B** Insuffisante.
- **C** Réservé à la maladie avancée avec mutation RET.
- **D** Le traitement curatif est chirurgical.

③ **Perle** Suivi : calcémie, TSH, calcitonine et ACE.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_007 audité

Q60 AP DX.1 · mécanisme KNDy

✅ **D** — Blocage du récepteur NK3 hypothalamique

① **Pourquoi c'est juste** Les œstrogènes freinent les neurones KNDy (kisspeptine, neurokinine B, dynorphine) de l'hypothalamus ; à la ménopause, ce frein disparaît et la zone thermoneutre se rétrécit. Le fézolinétant bloque le récepteur NK3 de la neurokinine B (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ce n'est pas une hormone.
- **B** Mécanisme des ISRS, hors AIPS pour les bouffées.
- **C** Mécanisme de la clonidine.
- **E** Mécanisme de l'aspirine.

③ **Perle** Contre-indiqué avec un inhibiteur du CYP1A2 comme la fluvoxamine.

④ **Source** Phase B DX.1 §3 · LOT_007 audité

Q61 **AP** **DX.1 · CYP1A2**

✅ **E** — Ne pas prescrire le fézolinétant

① **Pourquoi c'est juste** Le fézolinétant est contre-indiqué avec un inhibiteur du CYP1A2 comme la fluvoxamine (AIPS VEOZA™) (DX.1). On discute un THM ou une autre option.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Interaction contre-indiquée.
- **B** Maximum 45 mg.
- **C** Pas d'adaptation prévue : contre-indication.
- **D** La FSH n'a pas de rôle ici.

③ **Perle** Autres contre-indications : Child-Pugh B ou C, DFGe < 30 mL/min/1,73 m^2.

④ **Source** Phase B DX.1 §13 · LOT_007 audité

Q62 **AP** **DX.2 · dermocorticoïde**

✅ **A** — Sevrage progressif du dermocorticoïde

① **Pourquoi c'est juste** Un dermocorticoïde sur le visage provoque une dermatose rosacéiforme, à sevrer progressivement ; elle est un critère d'exclusion de la rosacée (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Entretient la dermatose rosacéiforme.
- **C** La rosacée n'est pas une indication AIPS de l'isotrétinoïne.
- **D** Le dermocorticoïde est la cause.
- **E** Diagnostic clinique.

③ **Perle** Les télangiectasies peuvent aussi être produites par la corticothérapie locale.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_007 audité

Q63 **AP** **DX.3 · propranolol et asthme**

✅ **B** — Propranolol contre-indiqué : asthme

① **Pourquoi c'est juste** L'AIPS d'Inderal® contre-indique le propranolol en cas d'asthme ou de bronchospasme (DX.3). On privilégie la TCC.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué par l'AIPS en cas d'asthme.
- **C** L'association ne lève pas la contre-indication.
- **D** La contre-indication ne dépend pas de la dose.
- **E** Pas de forme cutanée ; même contre-indication.

③ **Perle** Autres contre-indications : bradycardie, BAV 2–3, phéochromocytome non traité.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_007 audité

Q64 **AP** **DX.4 · TSH-R-Ab**

✅ **A** — Anticorps anti-récepteur de la TSH

① **Pourquoi c'est juste** Thyrotoxicose confirmée avec TSH-R-Ab positifs, thyroïde hypervascularisée et orbitopathie : diagnostic direct de maladie de Basedow (ETA 2018) (DX.4). Thionamide en première intention, 12 à 18 mois.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Cible les cellules C.
- **C** Marqueur de suivi des cancers différenciés.
- **D** Sans nodule suspect.
- **E** L'iode peut aggraver la thyrotoxicose.

③ **Perle** Un goitre diffus évoque Basedow ; un nodule dur évoque le carcinome médullaire.

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_007 audité

Q65 **AP** **DX.4 · propranolol masque**

✅ **E** — Le propranolol soulage sans traiter la cause

① **Pourquoi c'est juste** L'Inderal® soulage seulement les symptômes adrénergiques ; il ne traite pas la cause et peut masquer la thyrotoxicose (AIPS) (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il n'agit pas sur la sécrétion.
- **B** Effet symptomatique seulement.
- **C** Il s'ajoute au thyréostatique.
- **D** Aucune action immunologique.

③ **Perle** Excès d'hormones thyroïdiennes = chaleur produite, puis vasodilatation de dissipation.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_007 audité

Q66 **AP** **DX.5 · acétaldéhyde**

✅ **C** — Accumulation d'acétaldéhyde vasodilatateur

① **Pourquoi c'est juste** L'alcool est oxydé en acétaldéhyde, dégradé par l'ALDH2 ; un déficit en ALDH2 fait s'accumuler l'acétaldéhyde, vasodilatateur (DX.5). Le disulfirame reproduit ce blocage.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme carcinoïde.
- **B** Mécanisme de la mastocytose.
- **D** Mécanisme du phéochromocytome.
- **E** Mécanisme médicamenteux.

③ **Perle** Flush dans les minutes après l'alcool : déficit en ALDH2 ou interaction médicamenteuse.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_007 audité

Q67 **AP** **DX.5 · risque œsophagien**

✅ **B** — Abstinence : risque de cancer de l'œsophage

① **Pourquoi c'est juste** Le déficit en ALDH2 expose au cancer de l'œsophage : on conseille l'abstinence (Brooks 2009) (DX.5). Le flush à l'alcool n'est pas toujours bénin.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le risque de cancer augmente.
- **C** Masque le flush sans réduire le risque.
- **D** Le disulfirame provoque le flush.
- **E** Le flush signale un risque de cancer.

③ **Perle** Antihistaminique avant l'alcool : masque l'alarme, ne protège pas.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_007 audité

Q68 **AP** **DX.6 · niacine et PGD2**

✅ **C** — PGD2 sur le récepteur DP1 cutané

① **Pourquoi c'est juste** La niacine libère la prostaglandine D2, qui active le récepteur DP1 des vaisseaux cutanés (DX.6). L'aspirine prise avant la dose en réduit l'effet en bloquant la COX.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme du flush à l'alcool.
- **B** Mécanisme du red man à la vancomycine.
- **D** Mécanisme de l'amlodipine.
- **E** Mécanisme carcinoïde.

③ **Perle** L'usage préventif de l'aspirine est hors AIPS (recommandation internationale).

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_007 audité

Q69 **AP** **DX.6 · red man non allergique**

✅ **C** — Non : histamine liée au débit

① **Pourquoi c'est juste** Le red man est une libération d'histamine dépendante du débit, qui régresse à l'arrêt : ce n'est pas une allergie vraie (DX.6). Débit maximal 10 mg/min, au moins 60 minutes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ce n'est pas une allergie vraie.
- **B** Reprise possible à débit lent.
- **D** Le mécanisme est la libération d'histamine.
- **E** Inutile.

③ **Perle** Urticaire, stridor ou hypotension changent la donne : arrêt et adrénaline i.m.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_007 audité

Q70 **AP** **DX.8 · tryptase normale**

✅ **E** — L'anaphylaxie reste le diagnostic

① **Pourquoi c'est juste** L'anaphylaxie est un diagnostic clinique ; une tryptase normale ne l'exclut pas : 36 à 40 % des patients restent sous 11,4 µg/L (DX.8). On dose aussi la tryptase basale après 24 heures.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La tryptase normale n'exclut pas l'anaphylaxie.
- **B** Urticaire et bronchospasme : non.
- **C** Diagnostic d'exclusion.
- **D** N'explique pas l'urticaire ni l'hypotension.

③ **Perle** 36 à 40 % des anaphylaxies ont une tryptase normale.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_007 audité

Q71 **AP** **DX.8 · angio-œdème sous IEC**

✅ **C** — Bradykinine

① **Pourquoi c'est juste** Un angio-œdème sans papules ni prurit sous IEC est médié par la bradykinine : l'antihistaminique n'agit pas, l'adrénaline peu (DX.8). En cas de doute avec une anaphylaxie ou d'obstruction, on injecte l'adrénaline et on sécurise les voies aériennes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antihistaminique serait efficace ; ici il ne l'est pas.
- **B** Mécanisme du flush à l'alcool.
- **D** Mécanisme carcinoïde.
- **E** Mécanisme du phéochromocytome.

③ **Perle** Bilan : C4 et C1-INH si histoire familiale.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_007 audité

Q72 **AP** **DX.9 · métastases hépatiques**

✅ **E** — Le foie inactive les médiateurs portaux

① **Pourquoi c'est juste** Les médiateurs libérés dans la veine porte sont inactivés par le foie ; le syndrome carcinoïde n'apparaît que lorsqu'ils y échappent, le plus souvent par des métastases hépatiques (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle sécrète, mais le foie inactive.
- **B** Le premier filtre est hépatique.
- **C** Elles la stockent, elles ne la détruisent pas.
- **D** Le foie est le filtre principal.

③ **Perle** Les médiateurs : tachykinines, kinines et sérotonine.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_007 audité

Q73 **AP** **DX.9 · chromogranine A**

✅ **D** — Pas de syndrome carcinoïde

① **Pourquoi c'est juste** Le syndrome carcinoïde associe un symptôme (diarrhée chronique ou flush) et une sérotonine ou un 5-HIAA élevé (ENETS 2022). La chromogranine A, marqueur général des TNE, ne pose pas le syndrome (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La chromogranine A ne distingue pas les patients avec ou sans syndrome.
- **B** Aucun argument.
- **C** Aucun argument.
- **E** Aucun argument.

③ **Perle** Ni le symptôme seul, ni le 5-HIAA seul, ni l'imagerie seule ne suffisent.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_007 audité

Q74 **AP** **DX.10 · faux positif**

✅ **E** — Refaire le dosage, couché 30 min, à jeun

① **Pourquoi c'est juste** Métanéphrines légèrement élevées : possible faux positif (médicament, stress, prélèvement) ; on refait le dosage dans de bonnes conditions, couché 30 minutes, à jeun depuis la veille (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un résultat limite impose d'abord de contrôler les interférences.
- **B** Diagnostic non établi.
- **C** Réservée aux métastases suspectées.
- **D** Faux positif possible.

③ **Perle** Spécificité 89 % : les faux positifs existent.

④ **Source** Phase B DX.10 §9 · LOT_007 audité

Q75 **AP** **DX.10 · régime salé**

✅ **D** — Prévenir l'hypotension postopératoire

① **Pourquoi c'est juste** La vasoconstriction chronique réduit le volume plasmatique ; le régime salé et les apports hydriques préviennent l'hypotension après l'exérèse (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ce n'est pas le but.
- **B** Aucun effet sur la tumeur.
- **C** Sans rapport.
- **E** Sans rapport.

③ **Perle** Après l'exérèse : remplissage abondant, surveillance glycémique 48 h (hypoglycémie possible).

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_007 audité

Q76 **AP** **DX.11 · critères OMS**

✅ **A** — Mastocytose systémique confirmée

① **Pourquoi c'est juste** Critère majeur (agrégats ≥ 15 mastocytes) plus un critère mineur (KIT D816V) : diagnostic de mastocytose systémique (OMS 2022) (DX.11). Trois critères mineurs suffisent aussi.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un majeur et un mineur suffisent.
- **C** La peau n'est pas nécessaire.
- **D** Ce n'est qu'un critère mineur parmi d'autres.
- **E** Classification selon l'OMS ensuite.

③ **Perle** Mineurs : > 25 % mastocytes atypiques, KIT D816V, CD25/CD2/CD30, tryptase ≥ 20.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_007 audité

Q77 **AP** **DX.11 · tryptase sous 20**

✅ **C** — KIT D816V dans le sang

① **Pourquoi c'est juste** Après une anaphylaxie au venin, même avec une tryptase sous 11,5 µg/L, on cherche KIT D816V dans le sang (DX.11) : 13 patients sur 48 avaient une tryptase ≤ 20 sans lésion cutanée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une tryptase < 20 µg/L ne l'exclut pas.
- **B** Pas de lésion cutanée.
- **D** Sans argument carcinoïde.
- **E** Le bilan clonal est indiqué.

③ **Perle** KIT D816V sanguin négatif n'exclut pas : la moelle reste obligatoire si la suspicion est forte.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_007 audité

Q78 **AP** **DX.12 · calcitonine faussement élevée**

✅ **D** — Refaire et chercher une cause non tumorale

① **Pourquoi c'est juste** Une calcitonine légèrement élevée seule ne suffit pas : l'insuffisance rénale, les IPP et d'autres TNE peuvent l'élever (DX.12). On la refait et on cherche une cause non tumorale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une élévation légère isolée ne suffit pas.
- **B** Réservé à la maladie avancée confirmée.
- **C** Les cellules C ne fixent pas l'iode.
- **E** L'insuffisance rénale et les IPP élèvent la calcitonine.

③ **Perle** Calcitonine > 100 ng/L : carcinome médullaire probable.

④ **Source** Phase B DX.12 §8 · LOT_007 audité

Q79 **AP** **DX.12 · lévothyroxine**

✅ **E** — TSH normale

① **Pourquoi c'est juste** Après thyroïdectomie pour carcinome médullaire, la substitution vise une TSH normale : les cellules C ne dépendent pas de la TSH (ATA 2015, hors AIPS) (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les cellules C ne dépendent pas de la TSH.
- **B** Hypothyroïdie inutile.
- **C** Thyrotoxicose iatrogène.
- **D** Substitution à vie après thyroïdectomie totale.

③ **Perle** La fourchette AIPS 150–300 µg vise la suppression des cancers différenciés.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_007 audité

Q80 **AP** **DX.7 · consigne hypothalamique**

✅ **A** — Vasodilatation pour dissiper la chaleur

① **Pourquoi c'est juste** Pyrogènes et PGE2 relèvent la consigne hypothalamique (frissons) ; quand elle redescend, la vasodilatation cutanée dissipe la chaleur, d'où flush et sueurs (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Mécanisme allergique.
- **C** Mécanisme adrénergique.
- **D** Mécanisme alcoolique.
- **E** Mécanisme du carcinome médullaire.

③ **Perle** Un antipyrétique agit sur la consigne ; il n'agit pas sur l'hyperthermie.

④ **Source** Phase A §7 Approche syndromique · LOT_007 audité

Q81 **EX** **DX.8 · attendre la tryptase**

✅ **A** — Adrénaline i.m. immédiate, tryptase ensuite

① **Pourquoi c'est juste** La tryptase se prélève dans les heures suivantes (15 minutes à 3 heures) ; elle ne retarde jamais l'adrénaline (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le résultat ne doit jamais retarder l'adrénaline.
- **C** L'adrénaline est la première ligne.
- **D** Seconde ligne.
- **E** Dangereux et hors sujet.

③ **Perle** Œdème de la langue ou de la gorge : l'obstruction laryngée tue en minutes.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_007 audité

Q82 **EX** **DX.10 · bêtabloquant seul**

✅ **C** — Propranolol

① **Pourquoi c'est juste** Le bêtabloquant seul laisse l'effet alpha sans opposition et peut provoquer une crise hypertensive (DX.10). L'alpha-blocage vient toujours d'abord.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Alphabloquant : possible en crise.
- **B** Alphabloquant : utilisé en préparation (hors AIPS).
- **D** Vasodilatateur de crise.
- **E** Sans danger.

③ **Perle** AIPS du propranolol : phéochromocytome « seulement en association avec un alphabloquant ».

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_007 audité

Q83 **AP** **DX.1 · FSH piège**

✅ **B** — Bouffées de la ménopause probables

① **Pourquoi c'est juste** La FSH varie d'un jour à l'autre en périménopause : une valeur isolée ne pose ni n'exclut le diagnostic, qui est clinique (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La FSH varie d'un jour à l'autre en périménopause.
- **C** Aucune triade.
- **D** Bouffées humides, pas de diarrhée.
- **E** Inutile : diagnostic clinique.

③ **Perle** Ne pas doser les hormones chez une femme de plus de 45 ans avec bouffées humides.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_007 audité

Q84 **EX** **DX.9 · banane et noix**

✅ **A** — Régime sans sérotonine 72 h avant

① **Pourquoi c'est juste** Le 5-HIAA urinaire des 24 heures exige un régime de 72 heures sans aliments riches en sérotonine (banane, noix), et si possible deux collectes (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La sérotonine alimentaire fausse le dosage.
- **C** Inutile.
- **D** Préparation de 72 heures.
- **E** Faux positif garanti.

③ **Perle** Seuil ENETS : > 50 µmol/24 h compatible avec le syndrome.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_007 audité

Q85 **EX** **DX.5 · disulfirame contre le flush**

✅ **B** — Disulfirame

① **Pourquoi c'est juste** Le disulfirame inhibe l'aldéhyde-déshydrogénase et provoque le flush : il sert au sevrage, jamais au traitement du flush (DX.5). Le traitement du flush à l'alcool est d'éviter l'alcool.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans lien, sans danger particulier.
- **C** Sans effet sur le risque, mais pas contre-indiquée.
- **D** Sans lien.
- **E** Sans lien.

③ **Perle** Antabus® : sevrage préalable d'environ 3 jours ; toute prise d'alcool provoque un flush.

④ **Source** Phase A §11 Prise en charge · LOT_007 audité

Q86 **AP** **DX.12 · iode radioactif**

✅ **E** — Les cellules C ne fixent pas l'iode

① **Pourquoi c'est juste** L'iode radioactif ne traite pas le carcinome médullaire : les cellules C ne fixent pas l'iode, contrairement aux cellules folliculaires (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Argument faux.
- **B** Inefficace dans ce cancer.
- **C** Faux.
- **D** Faux.

③ **Perle** Maladie avancée avec mutation RET : sélpercatinib ou vandétanib.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_007 audité

Q87 **SPE · Gynécologie** **DX.1 · tibolone**

✅ **E** — Non : récidive accrue

① **Pourquoi c'est juste** La tibolone (Livial®) est contre-indiquée après cancer du sein : récidive accrue (HR 1,40, IC 1,14–1,70, étude LIBERATE) (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiquée après cancer du sein.
- **B** La contre-indication ne dépend pas de la dose.
- **C** Sans rapport.
- **D** Le risque persiste.

③ **Perle** Livial® : au plus tôt 12 mois après les dernières règles, sans progestatif.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_007 audité

Q88 **SPE · Dermatologie** **DX.2 · doxycycline 40 mg**

✅ **A** — Dose anti-inflammatoire, sous le seuil antimicrobien

① **Pourquoi c'est juste** Oracea® 40 mg agit par effet anti-inflammatoire et non antibiotique : la dose est inférieure au seuil antimicrobien (DX.2). Contre-indiqué aux 2e et 3e trimestres de grossesse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** 40 mg est sous le seuil antimicrobien.
- **C** C'est le mécanisme de l'ivermectine.
- **D** Mécanisme de la brimonidine.
- **E** Mécanisme de l'isotrétinoïne.

③ **Perle** Oracea® : sinon seulement en cas de nécessité absolue pendant la grossesse.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_007 audité

Q89 SPE · Psychiatrie DX.3 · escitalopram

✅ **E** — 5 mg la 1re semaine, puis 10 mg

① **Pourquoi c'est juste** Dans le trouble panique, Cipralex® débute à 5 mg par jour la première semaine, puis 10 mg ; maximum 20 mg par jour (DX.3). Arrêt progressif sur 1 à 2 semaines au moins.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Démarrer bas : risque d'aggravation initiale.
- **B** Dépasse le maximum de 20 mg.
- **C** Schéma non prévu.
- **D** Les benzodiazépines ne se prescrivent pas en fond.

③ **Perle** Ne jamais arrêter brutalement un ISRS.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_007 audité

Q90 SPE · Endocrinologie DX.4 · iode et orbitopathie

✅ **D** — Iode radioactif

① **Pourquoi c'est juste** L'iode radioactif est contre-indiqué en cas d'orbitopathie active ou sévère (ETA 2018) (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Option définitive possible.
- **B** Option possible.
- **C** Recommandé.
- **E** Recommandé.

③ **Perle** Thionamide 12 à 18 mois dans la maladie de Basedow.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_007 audité

Q91 **SPE · Hématologie** **DX.5 · douleur à l'alcool**

✅ **A** — Imagerie et avis hématologique

① **Pourquoi c'est juste** Une douleur déclenchée par l'alcool avec adénopathies oriente vers un lymphome de Hodgkin ; ce n'est pas un flush (DX.5). Imagerie et avis hématologique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il s'agit d'une douleur, pas d'un flush.
- **C** Risque de méconnaître un lymphome.
- **D** Sans rapport.
- **E** Sans rapport.

③ **Perle** Toute douleur provoquée par l'alcool avec adénopathie impose une imagerie.

④ **Source** Phase B DX.5 §10 · LOT_007 audité

Q92 **SPE · Oncologie** **DX.6 · tamoxifène et paroxétine**

✅ **E** — Éviter : baisse de l'endoxifène

① **Pourquoi c'est juste** La paroxétine inhibe le CYP2D6, abaisse l'endoxifène et réduit l'efficacité du tamoxifène (AIPS) (DX.6). Les bouffées sous tamoxifène touchent 37,8 % des patientes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Interaction CYP2D6.
- **B** Avis oncologique avant toute modification.
- **C** Contre-indiqué dans un cancer hormonosensible.
- **D** Sans fondement.

③ **Perle** Flush de type ménopausique sous tamoxifène : rassurer et demander l'avis oncologique.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_007 audité

Q93 SPE · Médecine interne DX.7 · métamizole

✅ **D** — Formule sanguine

① **Pourquoi c'est juste** Le métamizole expose à une agranulocytose idiosyncrasique, possible à tout moment ; la fièvre en masque les signes (DX.7). Formule sanguine en urgence et arrêt du médicament.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ne cherche pas l'agranulocytose.
- **B** Le médicament doit être suspecté.
- **C** Ne montre pas les neutrophiles.
- **E** Pas d'argument endocarditique.

③ **Perle** Métamizole = dernier recours antipyrétique.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_007 audité

Q94 SPE · Oncologie DX.9 · vésicule

✅ **C** — Échographie de la vésicule biliaire

① **Pourquoi c'est juste** Les analogues de la somatostatine favorisent la lithiase biliaire : échographie de la vésicule avant, puis tous les 6 à 12 mois (AIPS) (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans rapport.
- **B** Sans rapport.
- **D** Sans rapport.
- **E** Sans rapport.

③ **Perle** Aussi : allongement du QT, stéatorrhée (enzymes pancréatiques).

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_007 audité

Q95 **SPE · Endocrinologie** **DX.10 · génétique**

✅ **D** — Test génétique proposé

① **Pourquoi c'est juste** Tous les patients avec phéochromocytome reçoivent un test génétique ; SDHx si paragangliome, SDHB si métastases (DX.10). Suivi à vie si risque élevé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Tous les patients reçoivent un test.
- **B** Trop tard pour le dépistage familial.
- **C** Suivi à long terme.
- **E** Sans génétique préalable.

③ **Perle** Facteurs de risque de récidive : jeune âge, paragangliome, mutation, tumeur ≥ 5 cm.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_007 audité

Q96 **SPE · Hématologie** **DX.11 · avapritinib indolent**

✅ **D** — 25 mg par jour, à jeun

① **Pourquoi c'est juste** Forme indolente symptomatique malgré le traitement : avapritinib (Ayvakyt®) 25 mg par voie orale à jeun, une fois par jour, dose maximale (AIPS) (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de la forme avancée.
- **B** Dose du GIST.
- **C** Posologie de la midostaurine.
- **E** Dépasse le maximum de la forme indolente.

③ **Perle** Avapritinib déconseillé si plaquettes < 50 G/L.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_007 audité

Q97 **SPE · Hématologie** **DX.11 · midostaurine**

✅ **B** — 100 mg deux fois par jour

① **Pourquoi c'est juste** Mastocytose avancée : midostaurine (Rydapt®) 100 mg deux fois par jour (AIPS) ; interrompre si neutrophiles < 1,0 G/L (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Posologie de l'avapritinib indolent.
- **C** Posologie de la leucémie aiguë myéloïde.
- **D** Posologie de l'avapritinib avancé.
- **E** Sans fondement.

③ **Perle** Formes avancées : agressive, avec néoplasie hématologique associée, leucémie à mastocytes.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_007 audité

Q98 **SPE · Oncologie** **DX.12 · sélpercatinib**

✅ **C** — 160 mg deux fois par jour

① **Pourquoi c'est juste** Sélpercatinib (Retsevmo®) : 160 mg deux fois par jour dès 50 kg, 120 mg en dessous (AIPS) (DX.12). LIBRETTO-531 : survie sans progression prolongée (HR 0,28).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose sous 50 kg.
- **B** Posologie du vandétanib.
- **D** Sans fondement.
- **E** Schéma faux.

③ **Perle** Vandétanib : 300 mg/j, ECG (QT) à 2–4 semaines puis 8–12 semaines.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_007 audité